ΔΩΡΟ 1 / 5 · ΚΙΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Άτλαντας Συχνότερων Ευρημάτων

Τα ευρήματα που θα συναντάτε συχνότερα σε ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική και υπερηχογράφημα· το καθένα δίπλα στη φυσιολογική του εικόνα και στον σωστό τρόπο περιγραφής του.

Περιεχόμενα

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον άτλαντα

Ενότητα 1 · Ακτινογραφία (απλή ακτινογραφία)

Ενότητα 2 · Αξονική Τομογραφία (ΑΤ)

Ενότητα 3 · Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ)

Ενότητα 4 · Υπερηχογράφημα (υπέρηχος και POCUS)

Επείγον; Τα 40 ευρήματα με μια ματιά

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον άτλαντα

Κάθε σελίδα ένα εύρημα: αριστερά η φυσιολογική αναφορά, δεξιά το εύρημα, από κάτω τι να αναζητήσετε και πώς να το γράψετε.

> *Αναγνωρίστε πρώτα το φυσιολογικό, έπειτα αναζητήστε τη διαφορά. Όταν δείτε το εύρημα, γράψτε το με τις σωστές λέξεις και με την ίδια σειρά.*

Η δομή κάθε σελίδας ευρήματος

Τι βλέπετε

Τα βασικά σημεία που ορίζουν το εύρημα. Αναζητήστε τα ένα προς ένα στην εικόνα.

Πώς περιγράφεται

Πρότυπη πρόταση που μπορείτε να προσαρμόσετε στη γνωμάτευσή σας. Συμπληρώστε τις αγκύλες (**[δεξιά/αριστερά]**, **... mm**) σύμφωνα με τη δική σας εξέταση.

Με τι μπορεί να συγχέεται

Παγίδες και φυσιολογικές παραλλαγές που δίνουν την ίδια εικόνα· ένδειξη για τη διάκρισή τους.

Επείγον;

Ναι ενημερώστε αμέσως · **Ανάλογα με την περίπτωση** αποφασίστε σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα · **Όχι** γνωμάτευση ρουτίνας.

Η ίδια μέθοδος 4 βημάτων

1. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Ταυτοποιήστε ασθενή, εξέταση, ημερομηνία και πρωτόκολλο· ελέγξτε την τεχνική ποιότητα· προσανατολιστείτε ως προς πλευρά, τομή και παράθυρο/ακολουθία.
2. **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Σαρώστε κάθε περιοχή κάθε φορά με την ίδια σειρά. Μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα.
3. **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Περιγράψτε με τον σωστό όρο (πυκνότητα / σήμα / ηχογένεια), εντόπιση, μέγεθος και όρια· συγκρίνετε με την παλαιά εξέταση και με την αντίθετη πλευρά.

4 **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Γράψτε πρόταση συμπεράσματος, διαφορική διάγνωση και σύσταση· ενημερώστε για το επείγον εύρημα και καταγράψτε την ενημέρωση στη γνωμάτευση.

Σχετικά με τις εικόνες

Οι εικόνες είναι πραγματικά παραδείγματα που επιλέχθηκαν για να δείξουν την τυπική εικόνα του ευρήματος. Οι λεζάντες περιγράφουν το ίδιο το εύρημα· λεπτομέρειες όπως πλευρά, λοβός ή μέτρηση διαφέρουν σε κάθε ασθενή και στη γνωμάτευση πρέπει να γράφονται από τη δική σας εξέταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

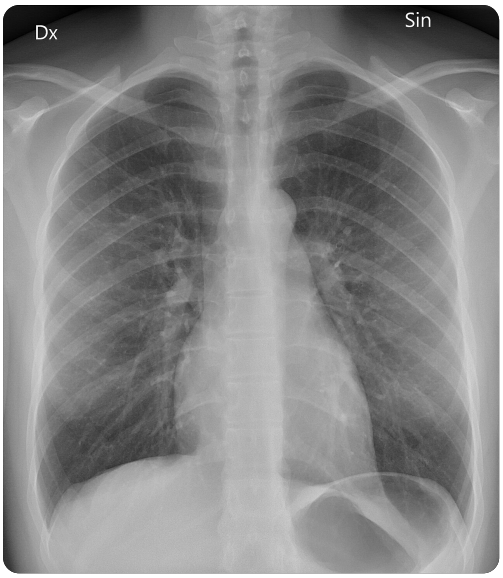
Ακτινογραφία (απλή ακτινογραφία)

Τα 10 ευρήματα που θα συναντάτε συχνότερα στην εφημερία σε ακτινογραφίες θώρακα, κοιλίας και οστών.

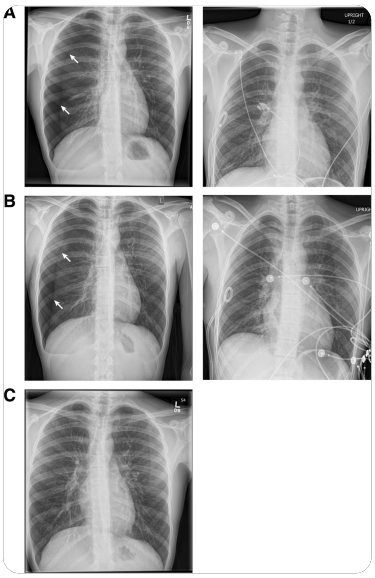
Τα ευρήματα αυτής της ενότητας και η επείγουσα προτεραιότητά τους:

01 · Πνευμοθώρακας	Ναι
02 · Υπεζωκοτική συλλογή	
03 · Λοβώδης πνευμονία (πύκνωση)	
04 · Ατελεκτασία	
05 · Καρδιομεγαλία	Όχι
06 · Πνευμονικό οίδημα	
07 · Πνευμοπεριτόναιο (ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα)	Ναι
08 · Απόφραξη λεπτού εντέρου	Ναι
09 · Κάταγμα περιφερικής κερκίδας	
10 · Οστεοαρθρίτιδα γόνατος	Όχι

01 · Πνευμοθώρακας



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA: η πνευμονική αγγειακή σκιαγράφηση εκτείνεται έως το θωρακικό τοίχωμα.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμοθώρακας. Αναζητήστε: λεπτή υπεζωκοτική γραμμή και απουσία αγγειακής σκιαγράφησης έξω από τη γραμμή.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Λεπτή, ευκρινής γραμμή σπλαγχνικού υπεζωκότα, παράλληλη προς το θωρακικό τοίχωμα.
- Απουσία πνευμονικής αγγειακής σκιαγράφησης έξω από τη γραμμή (υπερδιαυγαστική περιοχή).
- Σε ακτινογραφία σε ύπτια θέση: σημείο βαθιάς αύλακας, ευκρινέστερα περιγράμματα καρδιάς και διαφράγματος.
- Μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά, επιπέδωση του διαφράγματος, διεύρυνση των μεσοπλεύριων διαστημάτων: σημεία τάσης.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο [δεξιό/αριστερό] ημιθωράκιο παρατηρείται γραμμή του σπλαγχνικού υπεζωκότα που εκτείνεται από την κορυφή προς τα κάτω, χωρίς να διακρίνεται πνευμονική παρεγχυματική σκιαγράφηση περιφερικά αυτής· εύρημα συμβατό με πνευμοθώρακα. Δεν παρατηρείται μετατόπιση του μεσοθωρακίου.*

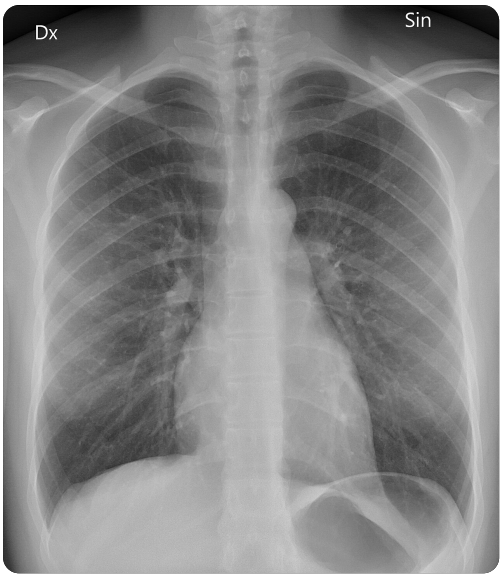
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Δερματική πτυχή (η γραμμή υπερβαίνει το θωρακικό τοίχωμα, η αγγειακή σκιαγράφηση συνεχίζεται πέρα από αυτήν).
- Έσω χείλος ωμοπλάτης, άκρη ρούχων ή σεντονιού.
- Μεγάλη πομφόλυγα (το έσω περίγραμμα είναι κοίλο, δεν πορεύεται παράλληλα με την υπεζωκοτική γραμμή).

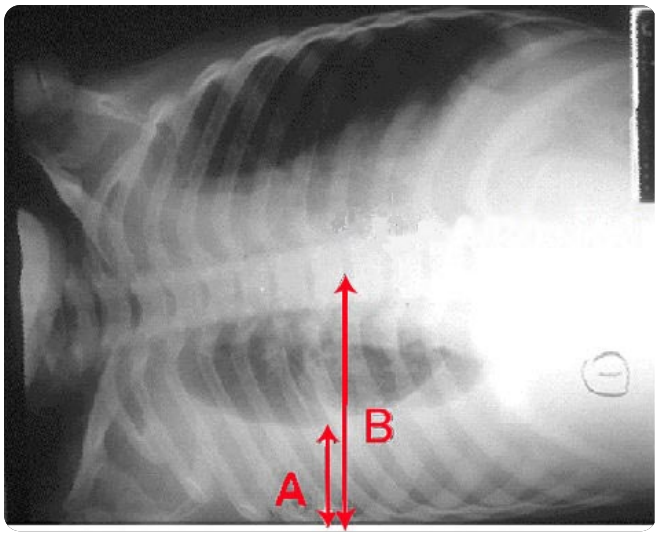
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Αναφέρετε κάθε νέο πνευμοθώρακα. Αν υπάρχει μετατόπιση του μεσοθωρακίου ή επιπέδωση του διαφράγματος, σκεφτείτε πνευμοθώρακα υπό τάση και επικοινωνήστε αμέσως με τον κλινικό ιατρό.

02 · Υπεζωκοτική συλλογή



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA: πλευροδιαφραγματικές γωνίες οξείες και ελεύθερες.



Σε αυτή την εικόνα: υπεζωκοτική συλλογή. Αναζητήστε: αμβλύνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας και άνω όριο σε σχήμα μηνίσκου.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Αμβλύνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας (πρώτο εύρημα σε μικρή συλλογή· στην πλάγια ακτινογραφία η οπίσθια γωνία γεμίζει νωρίτερα).
- Ομοιογενής σκίαση με κοίλο άνω όριο που ανέρχεται προς τα έξω (σημείο μηνίσκου).
- Σε μεγάλη συλλογή, σκίαση του ημιθωρακίου και ώθηση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά.
- Σε ύπτια ακτινογραφία το υγρό στρωματοποιείται προς τα πίσω: διάχυτη, θολή αύξηση της πυκνότητας στο ημιθωράκιο.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Η [δεξιά/αριστερή] πλευροδιαφραγματική γωνία είναι αμβλεία και παρατηρείται ομοιογενής σκίαση με άνω όριο σε διαμόρφωση μηνίσκου· εύρημα συμβατό με υπεζωκοτική συλλογή. Το παρακείμενο πνευμονικό παρέγχυμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί.*

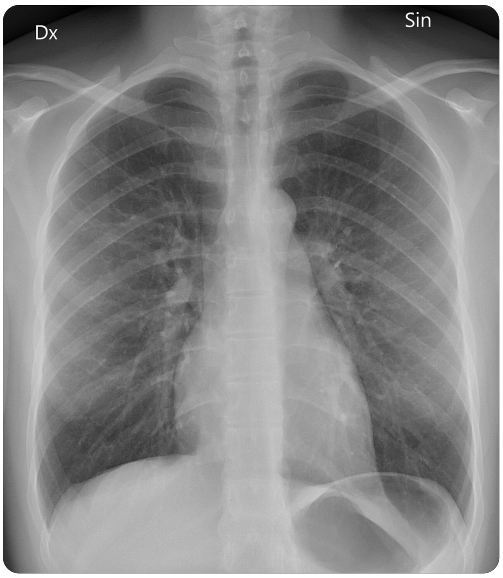
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Υπεζωκοτική πάχυνση ή παλαιά υπεζωκοτική ουλή (χωρίς μηνίσκο, δεν μεταβάλλεται).
- Υποπνευμονική συλλογή (μοιάζει με ανάσπαση του διαφράγματος).
- Πύκνωση ή σύμπτωση κάτω λοβού (στη συλλογή το μεσοθωράκιο μετατοπίζεται προς την αντίθετη πλευρά, στη σύμπτωση προς την ίδια).

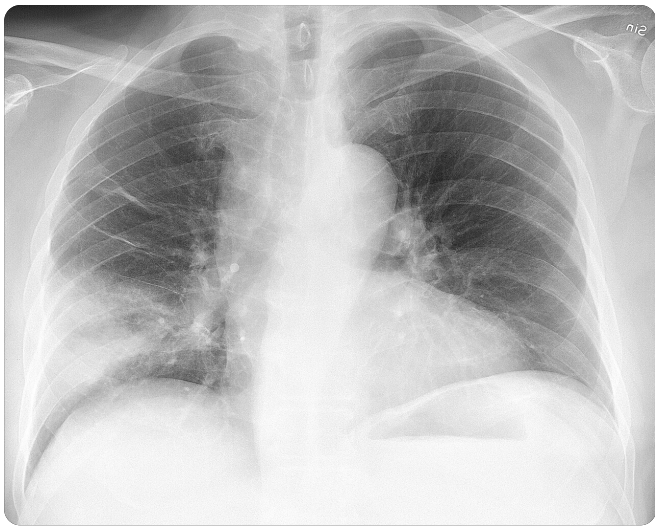
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Η μαζική συλλογή με μετατόπιση του μεσοθωρακίου ή η υποψία αιμοθώρακα σε τραύμα είναι επείγουσα. Η μικρή, γνωστή συλλογή γνωματεύεται ως ρουτίνα.

03 · Λοβώδης πνευμονία (πύκνωση)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA: σαφή περιγράμματα καρδιάς και διαφράγματος.



Σε αυτή την εικόνα: λοβώδης πύκνωση. Αναζητήστε: αεροβρογχόγραμμα και σημείο σιλουέτας.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ομοιογενής σκίαση που ακολουθεί τα όρια λοβού ή τμήματος και μπορεί να οριοθετείται σαφώς από μεσολόβια σχισμή.
- Διακλαδιζόμενα αεροβρογχογράμματα μέσα στη σκίαση.
- Σημείο σιλουέτας: εξάλειψη του γειτονικού περιγράμματος της καρδιάς ή του διαφράγματος (βοηθά στην εντόπιση).
- Δεν υπάρχει εμφανής απώλεια όγκου.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στη [δεξιά/αριστερή] [άνω/μέση/κάτω] ζώνη παρατηρείται περιοχή ομοιογενούς πύκνωσης με αεροβρογχογράμματα, που οριοθετείται από μεσολόβια σχισμή· συνιστάται εκτίμηση για πνευμονία σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα. Δεν παρατηρείται απώλεια όγκου.*

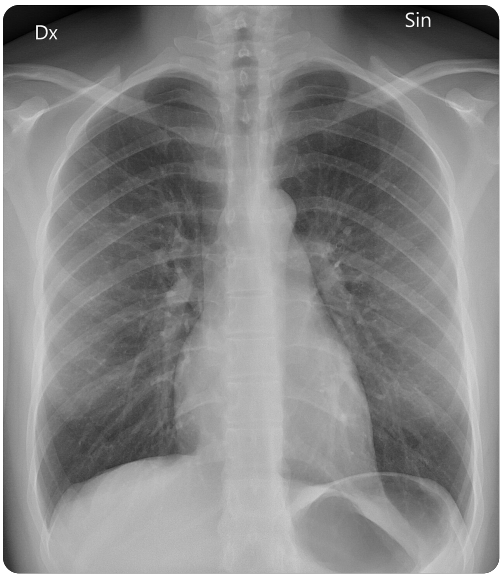
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Ατελεκτασία (υπάρχουν σημεία απώλειας όγκου).
- Υπεζωκοτική συλλογή (μηνίσκος, στρωμάτωση).
- Μάζα (κυρτό περίγραμμα, συνήθως χωρίς αεροβρογχόγραμμα)· σε ενήλικα μπορεί να συστηθεί ακτινογραφία ελέγχου μετά την ίαση.

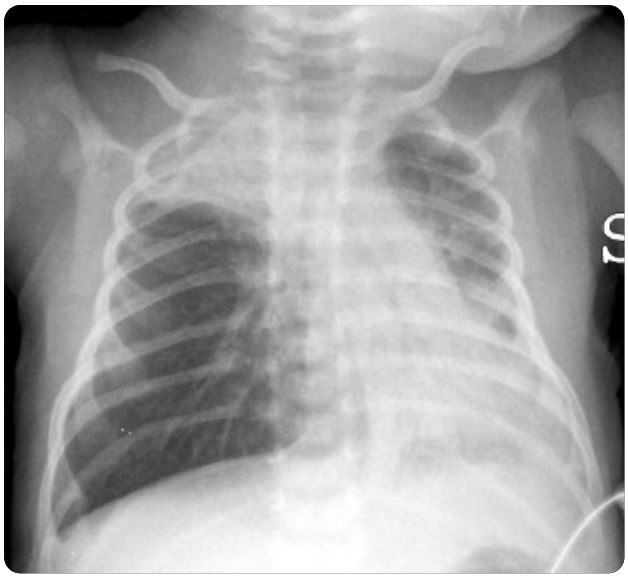
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Από μόνο του δεν απαιτεί επείγουσα ενημέρωση· σε διάχυτη, αμφοτερόπλευρη ή σπηλαιωτική εικόνα και κακή κλινική κατάσταση ενημερώστε στην ίδια εφημερία.

04 · Ατελεκτασία



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA: μεσολόβιες σχισμές, πύλες και διάφραγμα σε φυσιολογική θέση.



Σε αυτή την εικόνα: ατελεκτασία. Αναζητήστε: σημεία απώλειας όγκου μαζί με τη σκίαση.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Απώλεια όγκου: μετατόπιση της μεσολόβιας σχισμής, έλξη της πύλης, ανάσπαση του διαφράγματος.
- Μετατόπιση του μεσοθωρακίου και της τραχείας προς την ίδια πλευρά, στένωση των μεσοπλεύριων διαστημάτων.
- Τριγωνική ή ιστιοειδής σκίαση σε σύμπτωση λοβού.
- Αντιρροπιστική υπερδιάταση του γειτονικού πνεύμονα.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο επίπεδο του [δεξιού/αριστερού] [λοβού] παρατηρείται σκίαση με σημεία απώλειας όγκου, όπως μετατόπιση της μεσολόβιας σχισμής και έλξη της πύλης· εύρημα συμβατό με ατελεκτασία. Συνιστάται κλινική εκτίμηση για κεντρική αποφρακτική βλάβη και, εφόσον χρειάζεται, αξονική.*

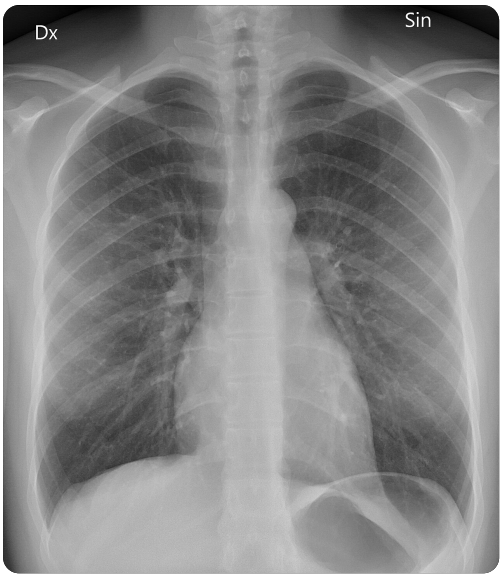
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Πύκνωση (ο όγκος διατηρείται ή αυξάνεται).
- Υπεζωκοτική συλλογή (το μεσοθωράκιο ωθείται προς την αντίθετη πλευρά).
- Εικόνα μετά από πνευμονεκτομή ή λοβεκτομή (ιστορικό και παλαιές εξετάσεις).

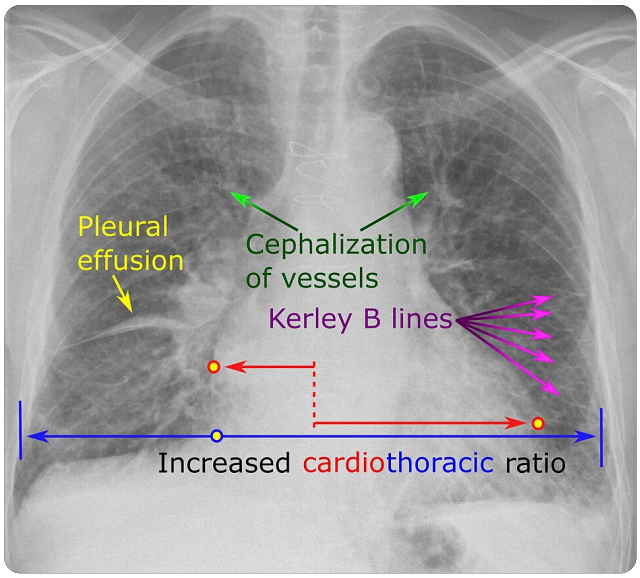
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Νέα λοβώδης σύμπτωση σε διασωληνωμένο ασθενή: ελέγξτε πρώτα τη θέση του άκρου του σωλήνα (διασωλήνωση κύριου βρόγχου). Σε ενήλικα με ανεξήγητη λοβώδη σύμπτωση σκεφτείτε κεντρική απόφραξη.

05 · Καρδιομεγαλία



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA: η καρδιακή σκιά δεν υπερβαίνει το μισό της εσωτερικής διαμέτρου του θώρακα.



Σε αυτή την εικόνα: καρδιομεγαλία. Αναζητήστε: αυξημένο καρδιοθωρακικό λόγο σε προβολή PA.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Καρδιοθωρακικός λόγος πάνω από 0,5 στην ακτινογραφία PA (μέγιστη διάμετρος καρδιάς / μέγιστη εσωτερική διάμετρος θώρακα).
- Ποια κοιλότητα υποδηλώνει το καρδιακό περίγραμμα (π.χ. επιμήκυνση του αριστερού περιγράμματος, προβολή του περιγράμματος του δεξιού κόλπου).
- Συνοδά ευρήματα: ανακατανομή της αιματικής ροής προς τα άνω, διάμεσο οίδημα, υπεζωκοτική συλλογή.
- Σε ακτινογραφία AP και σε ύπτια θέση η καρδιά φαίνεται μεγάλη· μην ερμηνεύετε εδώ τον λόγο.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στην ακτινογραφία θώρακα PA ο καρδιοθωρακικός λόγος είναι αυξημένος, εύρημα συμβατό με καρδιομεγαλία. Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να ληφθεί υπόψη περικαρδιακή συλλογή· εφόσον κρίνεται κλινικά απαραίτητο, συνιστάται υπερηχοκαρδιογράφημα.*

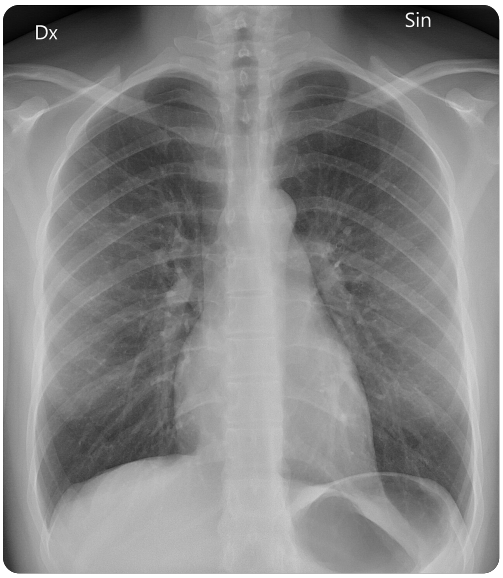
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Μεγέθυνση λόγω προβολής AP και ανεπαρκής εισπνοή.
- Περικαρδιακή συλλογή (ομαλά περιγράμματα, εικόνα «φιάλης νερού»).
- Περικαρδιακό λιπώδες επίθεμα, παραμόρφωση του θωρακικού τοιχώματος (κοίλος θώρακας).

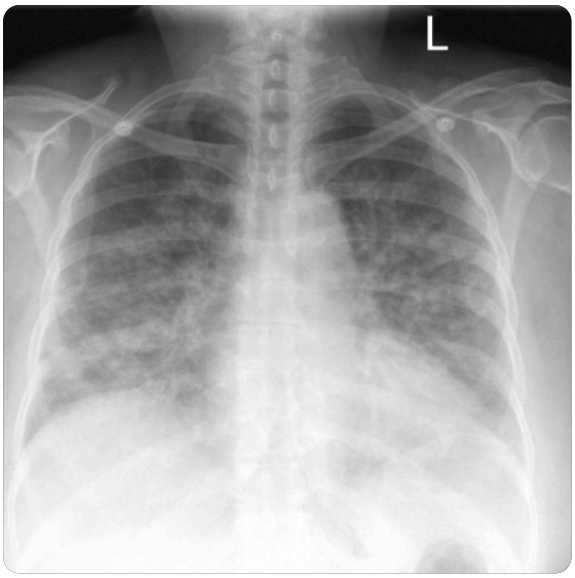
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Από μόνο του δεν είναι επείγον. Αν η καρδιακή σκιά μεγαλώνει γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ακτινογραφία και υπάρχει κλινική εικόνα επιπωματισμού, ενημερώστε αμέσως για επείγον υπερηχογράφημα.

06 · Πνευμονικό οίδημα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA: τα αγγεία της άνω ζώνης είναι λεπτότερα από αυτά των κάτω ζωνών.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμονικό οίδημα. Αναζητήστε: σημεία διάμεσου και κυψελιδικού οιδήματος.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Έντονη αγγειακή σκιαγράφηση στην άνω ζώνη (αγγειακή ανακατανομή / ανακατανομή προς τα άνω).
- Περιβρογχική πάχυνση και γραμμές Kerley B (βραχείες γραμμές στην περιφέρεια, κάθετες στον υπεζωκότα).
- Αμφοτερόπλευρες, κυρίως περιπυλαίες κυψελιδικές σκιάσεις («φτερά νυχτερίδας»).
- Αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή και συχνά καρδιομεγαλία.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρούνται κυψελιδικές σκιάσεις με αμφοτερόπλευρη περιπυλαία κατανομή, αύξηση των διάμεσων γραμμώσεων και αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή· η εικόνα είναι συμβατή με πνευμονικό οίδημα. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση [αυξημένα/μειωμένα/αμετάβλητα].*

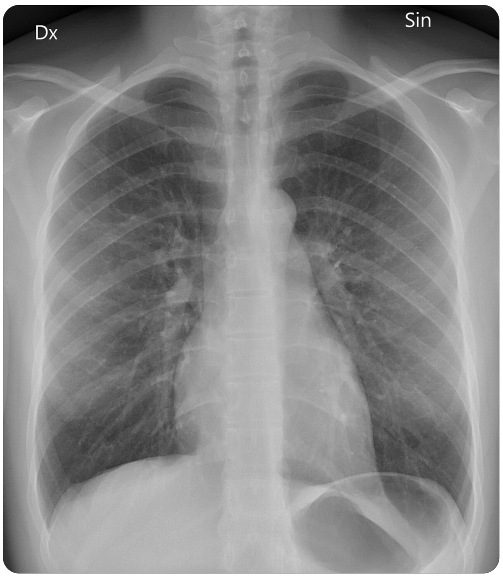
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Αμφοτερόπλευρη πνευμονία.
- ARDS (το μέγεθος της καρδιάς είναι συνήθως φυσιολογικό, συλλογή και διαφραγματικές γραμμές λιγότερο εμφανείς).
- Πνευμονική αιμορραγία.

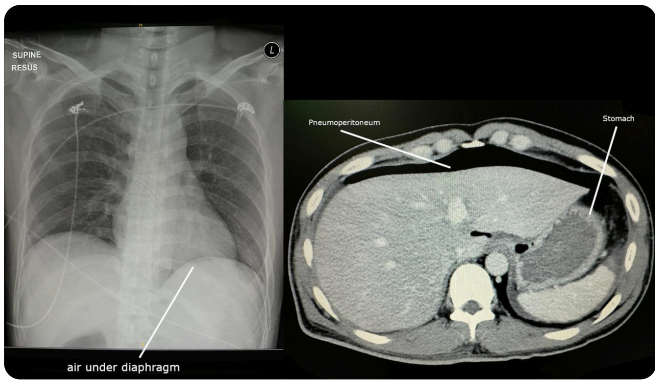
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Η κλινική είναι συνήθως γνωστή· ενημερώστε στην ίδια εφημερία για νεοεμφανιζόμενο ή ταχέως επιδεινούμενο οίδημα.

07 · Πνευμοπεριτόναιο (ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική όρθια ακτινογραφία θώρακα PA: χωρίς ελεύθερο αέρα κάτω από τον θόλο του διαφράγματος.



Σε αυτή την εικόνα: ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Αναζητήστε: λεπτή ημισεληνοειδή διαυγαστική περιοχή κάτω από τον θόλο.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ημισεληνοειδής ελεύθερος αέρας κάτω από το ημιδιάφραγμα σε όρθια ακτινογραφία θώρακα ή κοιλίας.
- Σημείο Rigler: διακρίνονται τόσο η έσω όσο και η έξω επιφάνεια του εντερικού τοιχώματος.
- Σε ύπτια ακτινογραφία, μεγάλη ωοειδής διαύγαση (σημείο «μπάλας ποδοσφαίρου»), ορατός δρεπανοειδής σύνδεσμος.
- Σε ασθενή που δεν μπορεί να σταθεί όρθιος: ακτινογραφία σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση ή αξονική.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται ημισεληνοειδής διαυγαστική εικόνα κάτω από τα ημιδιαφράγματα αμφοτερόπλευρα, συμβατή με ελεύθερο αέρα· ευρήματα υπέρ πνευμοπεριτοναίου. Συνιστάται επείγουσα κλινική εκτίμηση για διάτρηση κοίλου σπλάχνου. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό.*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Σημείο Chilaiditi (κόλον μεταξύ διαφράγματος και ήπατος· διακρίνονται οι κολικές πτυχές).
- Αέρας του θόλου του στομάχου (αριστερά, με υδραερικό επίπεδο και τοίχωμα στομάχου).
- Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση ή λαπαροσκόπηση (ρωτήστε οπωσδήποτε το ιστορικό).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Εκτός της αναμενόμενης μετεγχειρητικής περιόδου είναι κρίσιμο εύρημα: ενημερώστε αμέσως και καταγράψτε την ενημέρωση στη γνωμάτευση.

08 · Απόφραξη λεπτού εντέρου



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική απλή ακτινογραφία κοιλίας: αέρια στο παχύ έντερο και στο ορθό, λεπτό έντερο χωρίς διάταση.

Σε αυτή την εικόνα: απόφραξη λεπτού εντέρου. Αναζητήστε: διατεταμένες κεντρικές έλικες και υδραερικά επίπεδα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου με κεντρική εντόπιση (συχνός πρακτικός κανόνας: λεπτό έντερο 3 cm, παχύ έντερο 6 cm, τυφλό 9 cm).
- Κυκλικές πτυχές (valvulae conniventes) που διασχίζουν όλο το τοίχωμα (οι κολικές πτυχές δεν διασχίζουν πλήρως το τοίχωμα).
- Πολλαπλά υδραερικά επίπεδα σε διαφορετικά ύψη σε όρθια ακτινογραφία.
- Μείωση ή απουσία αερίων στο παχύ έντερο και στο ορθό.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρούνται διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου με κεντρική εντόπιση, στις οποίες διακρίνονται οι κυκλικές πτυχές, και πολλαπλά υδραερικά επίπεδα στην όρθια ακτινογραφία, με μειωμένα αέρια στο παχύ έντερο· ευρήματα υπέρ απόφραξης λεπτού εντέρου. Συνιστάται αξονική για την αιτιολογία και τις επιπλοκές.*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Παραλυτικός ειλεός (λεπτό και παχύ έντερο μαζί, αναλογική διάταση).
- Απόφραξη παχέος εντέρου (περιφερική εντόπιση, κολικές πτυχές).
- Γαστρεντερίτιδα (λίγα υδραερικά επίπεδα, χωρίς εμφανή διάταση).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Ενημερώστε τον κλινικό ιατρό στην ίδια εφημερία. Τα σημεία στραγγαλισμού και ισχαιμίας αναζητούνται με αξονική.

09 · Κάταγμα περιφερικής κερκίδας



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία άκρας χείρας-καρπού: φλοιός περιφερικής κερκίδας χωρίς διακοπή, ομαλά καρπικά τόξα.



Σε αυτή την εικόνα: κάταγμα περιφερικής κερκίδας. Αναζητήστε: διακοπή της συνέχειας του φλοιού στη μετάφυση και γωνίωση.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Διακοπή της συνέχειας του φλοιού και καταγματική γραμμή στη μετάφυση της περιφερικής κερκίδας.
- Γωνίωση του περιφερικού τμήματος (ραχιαία ή παλαμιαία) και βράχυνση στην πλάγια ακτινογραφία.
- Αν το κάταγμα επεκτείνεται στην κερκιδοκαρπική ή στην κάτω κερκιδωλενική άρθρωση.
- Συνοδό κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης· εξάλειψη της λιπώδους γραμμής του τετράγωνου πρηνιστή.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στη μετάφυση της [δεξιάς/αριστερής] περιφερικής κερκίδας παρατηρείται καταγματική γραμμή με [ραχιαία/παλαμιαία] γωνίωση, που [εκτείνεται/δεν εκτείνεται] στην αρθρική επιφάνεια. Στη στυλοειδή απόφυση της ωλένης [παρατηρείται κάταγμα/δεν παρατηρείται κάταγμα]. Η αρμονία της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης διατηρείται.*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Αυξητικός χόνδρος στο παιδί (αμφοτερόπλευρος, με ομαλά όρια· συγκρίνετε με την αντίθετη πλευρά).
- Θρεπτικός πόρος ή παλαιό, πωρωμένο κάταγμα.
- Κάταγμα σκαφοειδούς (μπορεί να συνυπάρχει με τον ίδιο μηχανισμό· αναζητήστε το χωριστά).

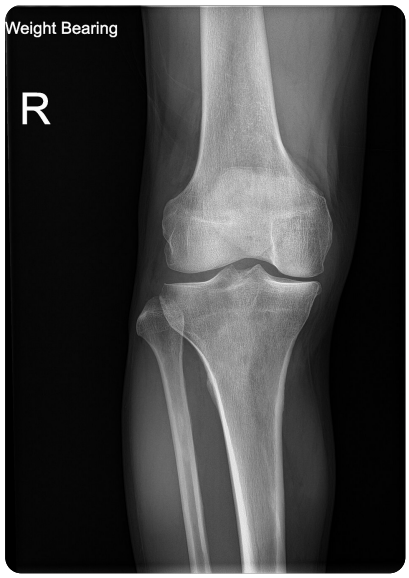
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Είναι κάταγμα των επειγόντων· γνωματεύστε το στην ίδια εφημερία. Αν υπάρχει ανοικτό κάταγμα, έντονη παρεκτόπιση ή νευροαγγειακό εύρημα, ενημερώστε αμέσως.

10 · Οστεοαρθρίτιδα γόνατος



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική ακτινογραφία γόνατος: έσω και έξω μεσάρθριο διάστημα διατηρημένα, ομαλά χείλη.



Σε αυτή την εικόνα: εκφυλιστική νόσος της άρθρωσης του γόνατος. Αναζητήστε: στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και οστεόφυτα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ασύμμετρη στένωση του μεσάρθριου διαστήματος (συνήθως έσω διαμέρισμα).
- Οριακά οστεόφυτα.
- Υποχόνδρια σκλήρυνση και υποχόνδριες κύστεις.
- Σε προχωρημένο στάδιο, διαταραχή του άξονα (ραιβότητα/βλαισότητα) και ελεύθερα σωμάτια.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στην άρθρωση του γόνατος παρατηρείται έντονη στένωση του μεσάρθριου διαστήματος στο [έσω/έξω] διαμέρισμα, οριακά οστεόφυτα και υποχόνδρια σκλήρυνση· ευρήματα συμβατά με εκφυλιστικές αλλοιώσεις (οστεοαρθρίτιδα).*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Φλεγμονώδης αρθρίτιδα (συμμετρική στένωση, διαβρώσεις, περιαρθρική οστεοπενία).
- Χονδρασβέστωση (ασβέστωση εντός του χόνδρου).
- Κάταγμα κνημιαίου κονδύλου σε τραύμα (μπορεί να διαφύγει ανάμεσα στα οστεόφυτα).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Δεν είναι επείγον· γνωματεύεται ως ρουτίνα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αξονική Τομογραφία (ΑΤ)

Τα 10 ευρήματα που δεν πρέπει να σας διαφύγουν στην αξονική εγκεφάλου και θώρακα.

Τα ευρήματα αυτής της ενότητας και η επείγουσα προτεραιότητά τους:

11 · Επισκληρίδιο αιμάτωμα — Ναι

12 · Υποσκληρίδιο αιμάτωμα — Ναι

13 · Υπαραχνοειδής αιμορραγία — Ναι

14 · Ενδοεγκεφαλική (ενδοπαρεγχυματική) αιμορραγία — Ναι

15 · Οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό (αξονική) — Ναι

16 · Υδροκέφαλος

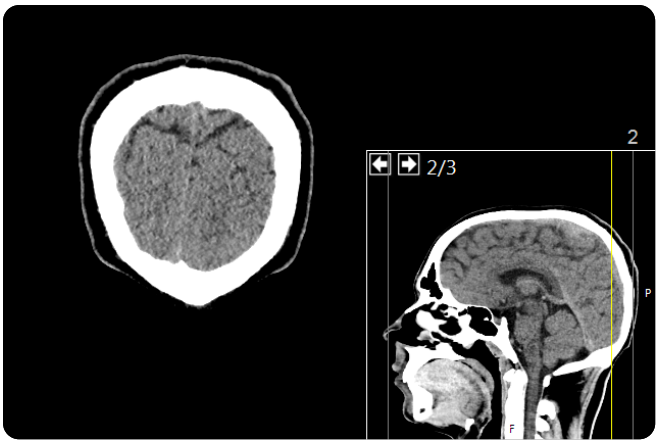
17 · Πνευμονική εμβολή (αξονική αγγειογραφία) — Ναι

18 · Αδιαφάνεια θολής υάλου

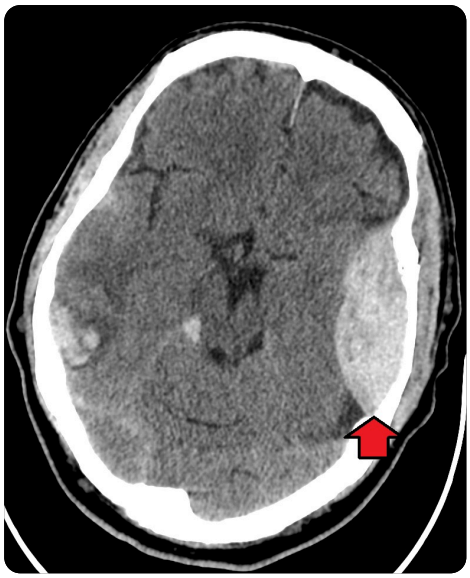
19 · Πνευμοθώρακας (αξονική) — Ναι

20 · Διαχωρισμός αορτής — Ναι

11 · Επισκληρίδιο αιμάτωμα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό: χωρίς συλλογή μεταξύ οστού και εγκεφάλου.



Σε αυτή την εικόνα: επισκληρίδιο αιμάτωμα. Αναζητήστε: αμφίκυρτη, υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Αμφίκυρτη (φακοειδής), υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή.
- Συνήθως δεν υπερβαίνει τις γραμμές των ραφών· συχνά υπάρχει υπερκείμενο κάταγμα του θόλου του κρανίου (οστικό παράθυρο).
- Υπόπυκνες περιοχές μέσα στο αιμάτωμα (σημείο «στροβίλου») υποδηλώνουν ενεργό αιμορραγία.
- Φαινόμενο μάζας: εξάλειψη αυλάκων, συμπίεση κοιλιών, μετατόπιση της μέσης γραμμής.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στη [δεξιά/αριστερή] [μετωπιαία/κροταφική/βρεγματική] χώρα παρατηρείται υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή αμφίκυρτης διαμόρφωσης, που δεν υπερβαίνει τη γραμμή των ραφών, συμβατή με οξεία φάση· εύρημα συμβατό με επισκληρίδιο αιμάτωμα. Μέγιστο πάχος ... mm, μετατόπιση της μέσης γραμμής ... mm. Στο οστικό παράθυρο καταγματική γραμμή στον παρακείμενο θόλο του κρανίου [παρατηρείται/δεν παρατηρείται].*

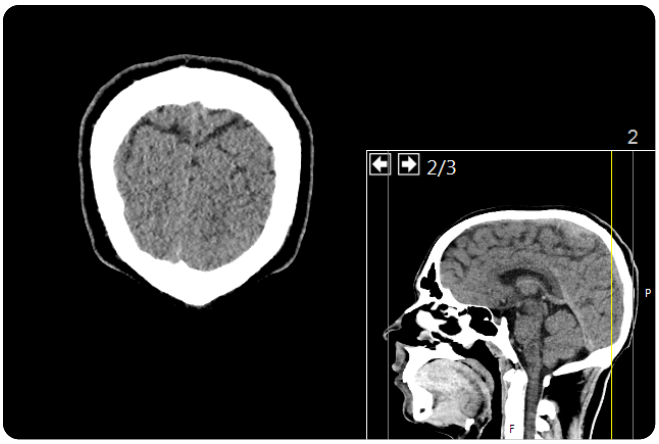
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (ημισεληνοειδές σχήμα, υπερβαίνει τις ραφές).
- Εξωαξονικός όγκος ή μετάσταση στη σκληρά μήνιγγα (ενισχύεται, διαφορετικό ιστορικό).

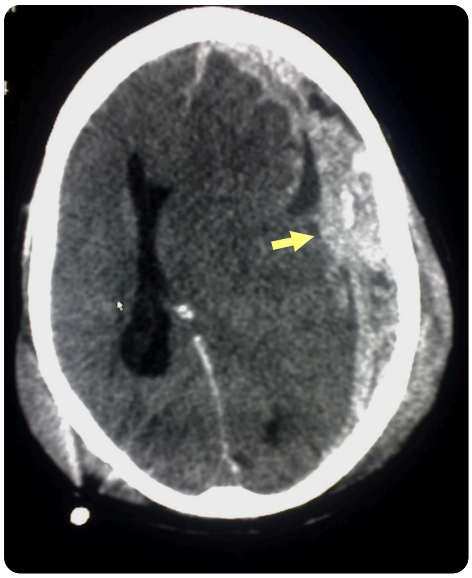
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Κρίσιμο εύρημα. Ενημερώστε αμέσως τη νευροχειρουργική και τον θεράποντα κλινικό ιατρό.

12 · Υποσκληρίδιο αιμάτωμα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου: οι αύλακες εκτείνονται έως τον θόλο του κρανίου.



Σε αυτή την εικόνα: υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Αναζητήστε: ημισεληνοειδή εξωαξονική συλλογή με κοίλο έσω όριο.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ημισεληνοειδές σχήμα, κοίλο έσω όριο που ακολουθεί την επιφάνεια του εγκεφάλου.
- Υπερβαίνει τις ραφές· μπορεί να εκτείνεται κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου, δεν υπερβαίνει τις αναδιπλώσεις της σκληράς μήνιγγας.
- Οξύ: υπέρπυκνο. Υποξύ: ισόπυκνο με τον εγκέφαλο (διαφεύγει). Χρόνιο: υπόπυκνο.
- Για λεπτές συλλογές: υποσκληρίδιο (ευρύ) παράθυρο και στεφανιαίες ανασυνθέσεις.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται ημισεληνοειδές υπέρπυκνο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συμβατό με οξεία φάση, που εκτείνεται κατά μήκος της [δεξιάς/αριστερής] [μετωποβρεγματικής] κυρτότητας. Μέγιστο πάχος ... mm, μετατόπιση της μέσης γραμμής ... mm.*

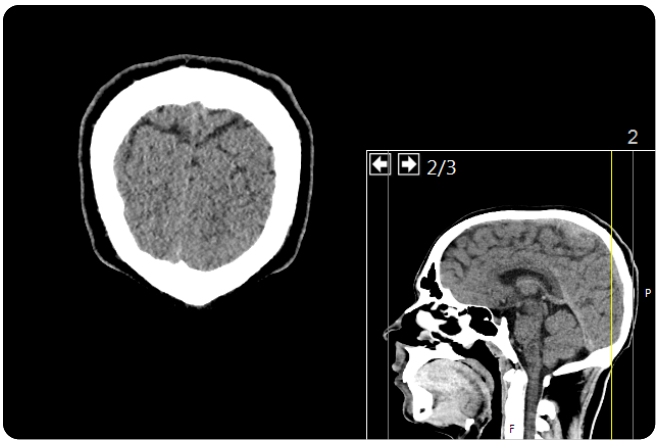
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Επισκληρίδιο αιμάτωμα (αμφίκυρτο, δεν υπερβαίνει τις ραφές).
- Υποσκληρίδιο ύγρωμα (πυκνότητα ΕΝΥ).
- Ισόπυκνο υποσκληρίδιο: η εξάλειψη των αυλάκων και η έσω ώθηση της λευκής ουσίας είναι η ένδειξη.

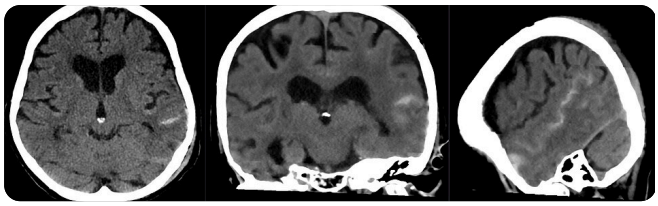
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα ή αυτό με φαινόμενα μάζας είναι κρίσιμο εύρημα· ενημερώστε αμέσως.

13 · Υπαραχνοειδής αιμορραγία



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου: βασικές δεξαμενές και σχισμές του Sylvius με πυκνότητα ΕΝΥ.



Σε αυτή την εικόνα: υπαραχνοειδής αιμορραγία. Αναζητήστε: υπέρπυκνη περιοχή στις δεξαμενές και στις αύλακες.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Υπέρπυκνη περιοχή στις βασικές δεξαμενές, στις σχισμές του Sylvius και στη μεσοημισφαιρική σχισμή.
- Λεπτές υπέρπυκνες γραμμές στις αύλακες της κυρτότητας.
- Στρωματοποιημένο αίμα στη μεσοσκελική δεξαμενή και στα ινιακά κέρατα (σε μικρές ποσότητες μπορεί να είναι το μόνο εύρημα).
- Συνοδός υδροκέφαλος και ενδοκοιλιακή αιμορραγία.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται υπέρπυκνη περιοχή στις βασικές δεξαμενές και στις σχισμές του Sylvius αμφοτερόπλευρα, συμβατή με υπαραχνοειδή αιμορραγία. Το κοιλιακό σύστημα [φυσιολογικό/διευρυμένο]. Συνιστάται αξονική αγγειογραφία για διερεύνηση ανευρύσματος. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό.*

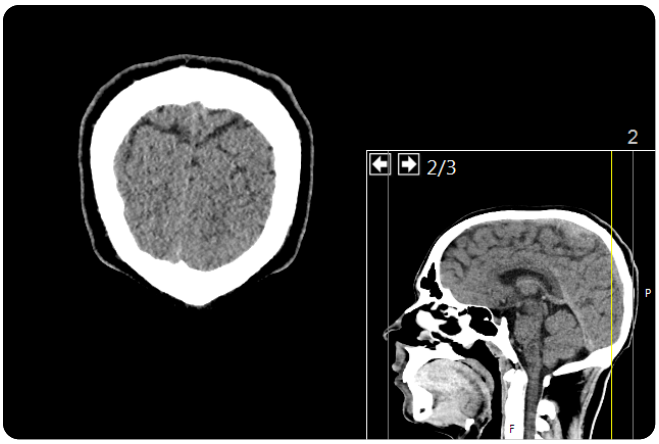
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Ψευδο-ΥΑΑ (σε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα οι δεξαμενές φαίνονται σχετικά υπέρπυκνες).
- Πρόσφατη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού.
- Ασβέστωση του δρεπάνου ή του σκηνιδίου, μηνιγγίτιδα.

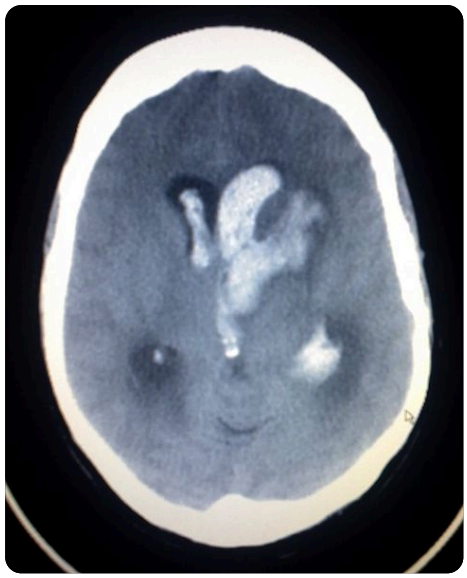
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Κρίσιμο εύρημα· ενημερώστε αμέσως και συστήστε αξονική αγγειογραφία.

14 · Ενδοεγκεφαλική (ενδοπαρεγχυματική) αιμορραγία



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου: χωρίς εστιακή μεταβολή πυκνότητας στο παρέγχυμα.



Σε αυτή την εικόνα: ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα. Αναζητήστε: υπέρπυκνη περιοχή μέσα στο παρέγχυμα και περιβάλλον οίδημα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Υπέρπυκνη περιοχή μέσα στο παρέγχυμα· περιφερικά υπόπυκνος δακτύλιος οιδήματος.
- Φαινόμενο μάζας και διάνοιξη στις κοιλίες.
- Η εντόπιση δίνει ενδείξεις: βασικά γάγγλια, θάλαμος, γέφυρα (υπερτασικές εντοπίσεις) και λοβώδης εντόπιση.
- Επίπεδο ή ετερογενές περιεχόμενο μπορεί να υποδηλώνει διαταραχή πήξης.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται οξύ ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα με [δεξιά/αριστερή] [βασικογαγγλιακή/λοβώδη] εντόπιση, διαστάσεων περίπου … × … mm, με περιβάλλοντα υπόπυκνο δακτύλιο οιδήματος. Διάνοιξη στις κοιλίες [υπάρχει/δεν υπάρχει], μετατόπιση της μέσης γραμμής … mm.*

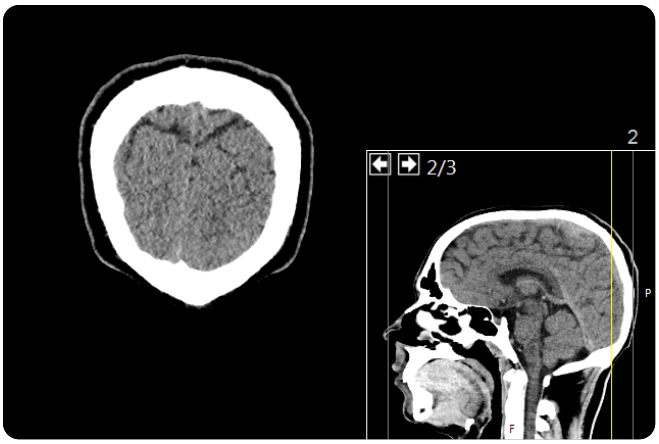
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Έμφρακτο με αιμορραγική μετατροπή.
- Αιμορραγικός όγκος ή μετάσταση (περισσότερο οίδημα από το αναμενόμενο· εξέταση με σκιαγραφικό).
- Ασβέστωση (η πυκνότητα είναι πολύ υψηλότερη).

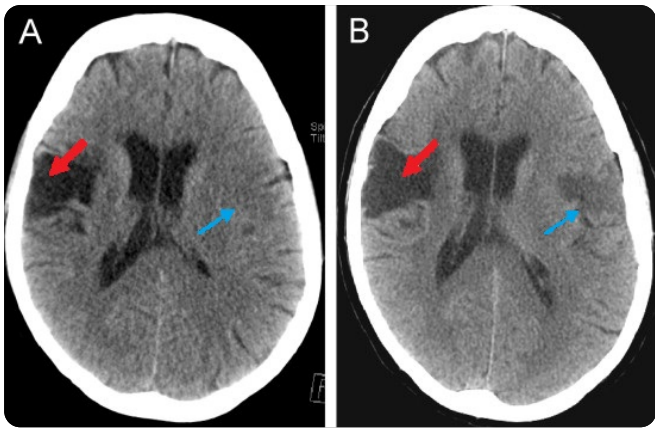
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Κρίσιμο εύρημα· ενημερώστε αμέσως.

15 · Οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό (αξονική)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου: σαφής διάκριση φαιάς-λευκής ουσίας, ο φλοιός της νήσου διακρίνεται.



Σε αυτή την εικόνα: υπόπυκνη περιοχή ισχαιμικού εμφράκτου. Αναζητήστε: υπόπυκνη περιοχή που αντιστοιχεί σε αγγειακή περιοχή.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Εξάλειψη της διάκρισης φαιάς-λευκής ουσίας· απώλεια της νησιδιακής ταινίας.
- Εξάλειψη του περιγράμματος του φακοειδούς πυρήνα· εξάλειψη αυλάκων.
- Υπόπυκνη περιοχή που αντιστοιχεί σε αγγειακή περιοχή μιας αρτηρίας (φαίνεται καλύτερα σε παράθυρο εγκεφαλικού).
- Τις πρώτες ώρες η αξονική μπορεί να είναι φυσιολογική: η φυσιολογική αξονική δεν αποκλείει το αγγειακό εγκεφαλικό.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται υπόπυκνη περιοχή που αντιστοιχεί στην αγγειακή περιοχή της [δεξιάς/αριστερής] [MCA], με εξάλειψη της διάκρισης φαιάς-λευκής ουσίας· εύρημα συμβατό με οξύ-υποξύ ισχαιμικό έμφρακτο. Δεν παρατηρείται ενδοκρανιακή αιμορραγία.*

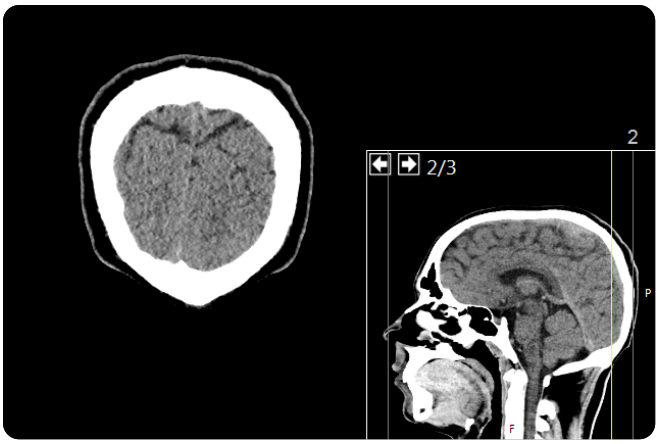
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Περιογκικό αγγειογενές οίδημα (δακτυλοειδής επέκταση στη λευκή ουσία, δεν αντιστοιχεί σε αγγειακή περιοχή).
- Παλαιό έμφρακτο (πυκνότητα ΕΝΥ, απώλεια όγκου, διεύρυνση γειτονικών αυλάκων).
- Εγκεφαλίτιδα, σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας.

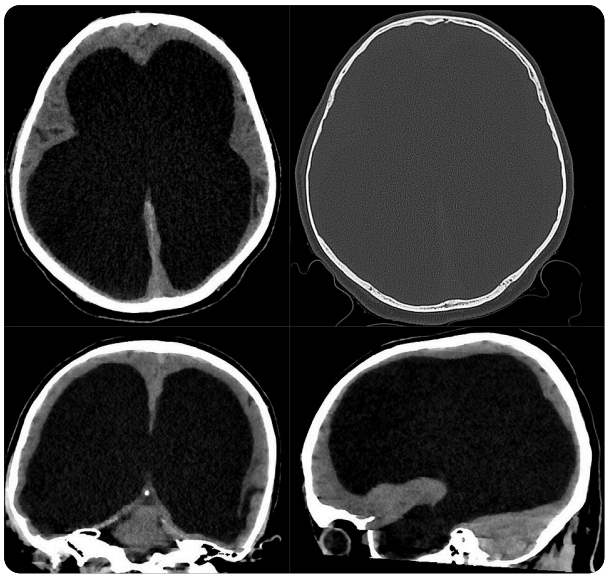
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Το πρώτο που θα πείτε για ασθενή σε πρωτόκολλο αγγειακού εγκεφαλικού: υπάρχει αιμορραγία ή όχι. Ενημερώστε αμέσως την ομάδα αγγειακού εγκεφαλικού.

16 · Υδροκέφαλος



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου: κοιλίες με μέγεθος ανάλογο προς τις αύλακες.



Σε αυτή την εικόνα: υδροκέφαλος. Αναζητήστε: διάταση των κοιλιών δυσανάλογη προς τις αύλακες.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Διάταση των πλάγιων κοιλιών και της τρίτης κοιλίας· εμφανή κροταφικά κέρατα.
- Αμυδρές αύλακες (διαφορική διάγνωση από την ατροφία).
- Περικοιλιακή υπόπυκνη περιοχή (διεπενδυματική διήθηση ΕΝΥ· υποδηλώνει οξεία εικόνα).
- Αναζητήστε το επίπεδο της απόφραξης (τέταρτη κοιλία, υδραγωγός, τρήματα).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται διάταση των πλάγιων κοιλιών και της τρίτης κοιλίας, δυσανάλογη προς τη διεύρυνση των αυλάκων, με εμφανή κροταφικά κέρατα. Η περικοιλιακή υπόπυκνη περιοχή μπορεί να είναι συμβατή με διεπενδυματική διήθηση ΕΝΥ. Υδροκέφαλος· συνιστάται σύγκριση με προηγούμενη εξέταση.*

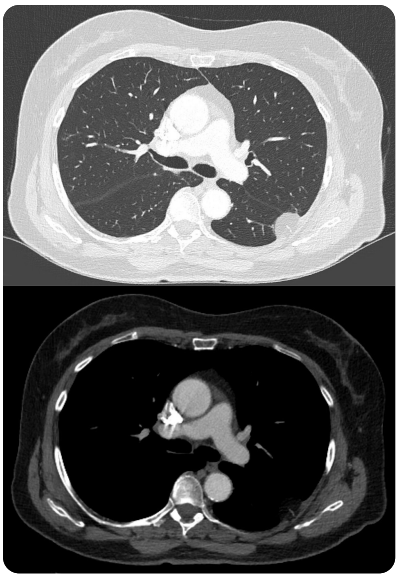
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Διάταση ex vacuo λόγω ατροφίας (και οι αύλακες είναι διευρυμένες).
- Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (κλινική διάγνωση· η απεικόνιση την υποστηρίζει).

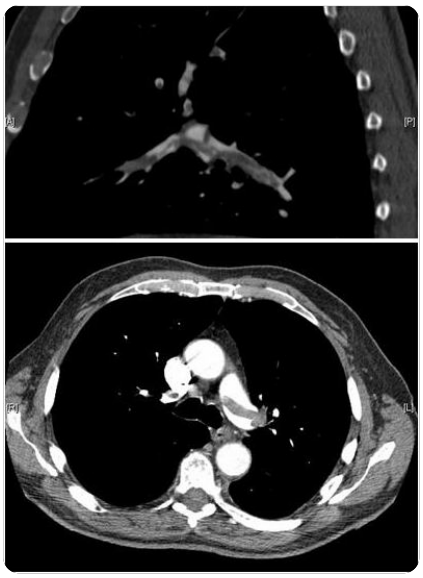
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Είναι επείγον αν είναι νεοεμφανιζόμενος, αυξανόμενος ή αν σε ασθενή με βαλβίδα παροχέτευσης υπάρχει υποψία δυσλειτουργίας της· ενημερώστε αμέσως.

17 · Πνευμονική εμβολή (αξονική αγγειογραφία)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική θώρακα με σκιαγραφικό (παράθυρο μεσοθωρακίου): οι πνευμονικές αρτηρίες γεμίζουν ομοιογενώς με σκιαγραφικό.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμονική εμβολή. Αναζητήστε: έλλειμμα πλήρωσης μέσα στην πνευμονική αρτηρία με σκιαγραφικό.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Έλλειμμα πλήρωσης σε κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας γεμάτο με σκιαγραφικό.
- Οξεία εμβολή: έλλειμμα στο κέντρο του αγγείου, που διατείνει το αγγείο και σχηματίζει οξεία γωνία με το σκιαγραφικό.
- Επιβάρυνση της δεξιάς καρδίας: αυξημένος λόγος RV/LV, επιπέδωση ή κύρτωση προς τα αριστερά του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
- Σφηνοειδής σκίαση με βάση στον υπεζωκότα στο παρέγχυμα (έμφρακτο).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στους [δεξιούς/αριστερούς] [κύριους/λοβαίους/τμηματικούς] κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας παρατηρούνται ελλείμματα πλήρωσης συμβατά με οξεία πνευμονική εμβολή. Σημεία επιβάρυνσης της δεξιάς καρδίας [υπάρχουν/δεν παρατηρούνται]. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό.*

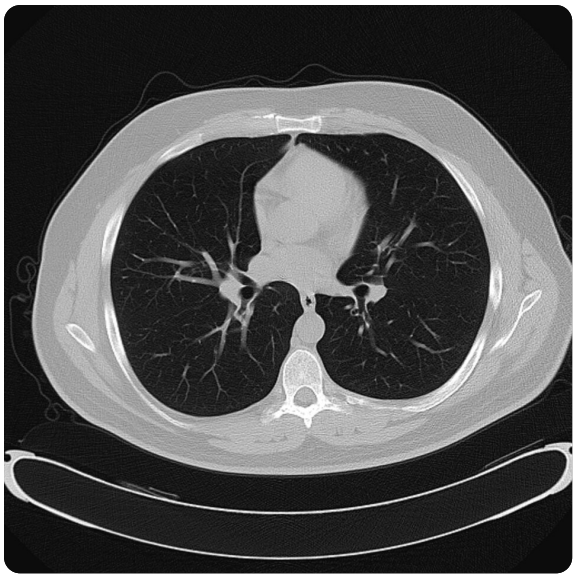
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Τέχνημα ροής (ανεπαρκές σκιαγραφικό, αναπνευστική κίνηση· ασαφή όρια ελλείμματος, χάνεται σε άλλη τομή).
- Πυλαίος λεμφαδένας (έξω από το αγγείο) ή βλεννώδες βύσμα μέσα στον βρόγχο.
- Χρόνια εμβολή (έκκεντρη, προσκολλημένη στο τοίχωμα, δίκτυο ή ταινία, στενωμένο αγγείο).

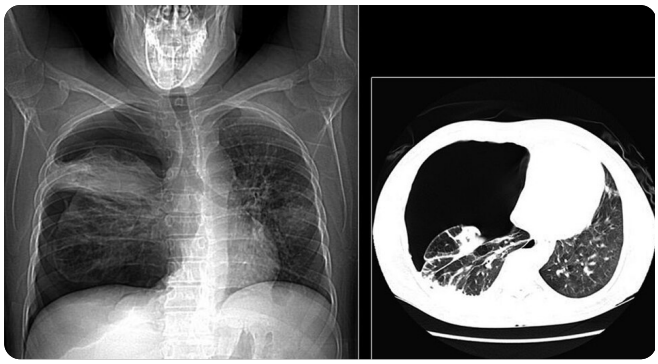
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Κρίσιμο εύρημα· ενημερώστε αμέσως, ιδίως αν υπάρχει κεντρική εμβολή ή επιβάρυνση της δεξιάς καρδίας.

18 · Αδιαφάνεια θολής υάλου



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική θώρακα (παράθυρο πνεύμονα): ομοιογενές παρέγχυμα, σαφή αγγεία.



Σε αυτή την εικόνα: αδιαφάνειες θολής υάλου. Αναζητήστε: ήπια αύξηση πυκνότητας που δεν εξαλείφει τα αγγεία.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ήπια αύξηση πυκνότητας στην οποία διακρίνονται τα υποκείμενα αγγεία και τα βρογχικά τοιχώματα (στην πύκνωση δεν διακρίνονται).
- Περιγράψτε την κατανομή: περιφερική ή κεντρική, άνω ή κάτω ζώνη, κατά τόπους ή διάχυτη.
- Συνοδά: πάχυνση των μεσολοβιδιακών διαφραγμάτων («λιθόστρωτο»), πύκνωση, συλλογή.
- Σε τομές κατά την εκπνοή μπορεί να εμφανιστεί ψευδής εικόνα θολής υάλου.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρούνται αμφοτερόπλευρες, κατά κύριο λόγο περιφερικές, κατά τόπους αδιαφάνειες θολής υάλου. Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη λοίμωξη (ιογενής/άτυπη), οίδημα, αιμορραγία και διάμεσες πνευμονοπάθειες· συνιστάται συνεκτίμηση με τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα.*

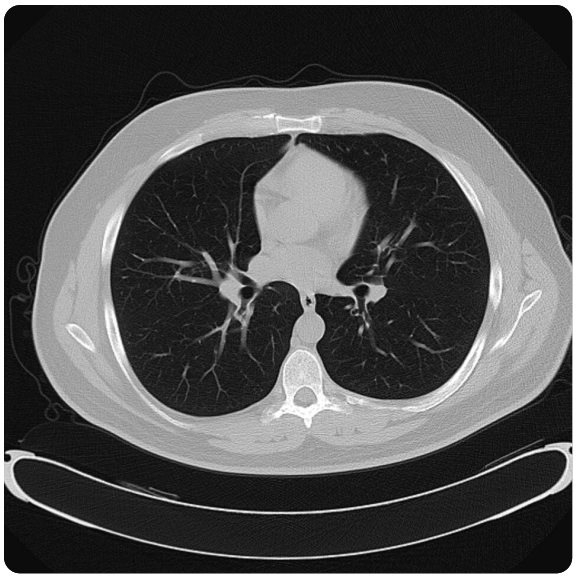
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Εκπνοή ή ανεπαρκής εισπνοή.
- Μωσαϊκή εξασθένηση (παγίδευση αέρα ή διαφορά αιμάτωσης· το εύρος των αγγείων διαφέρει).
- Τέχνημα κίνησης.

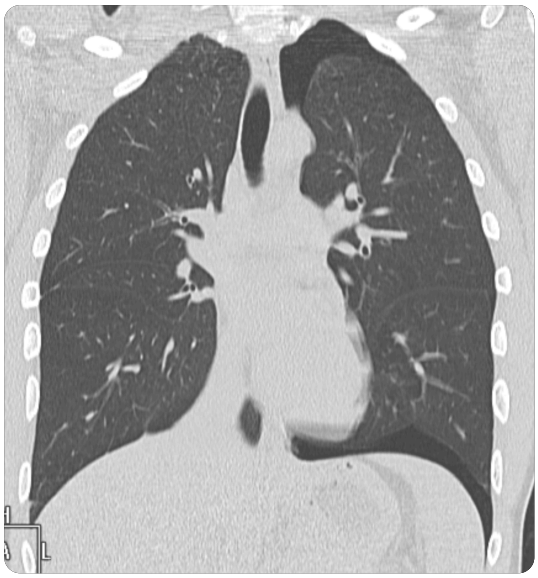
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Σε διάχυτη, νέα εικόνα και σε υποξαιμικό ασθενή ενημερώστε στην ίδια εφημερία· η τυχαία εστιακή θολή ύαλος γνωματεύεται με σύσταση παρακολούθησης.

19 · Πνευμοθώρακας (αξονική)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική θώρακα (παράθυρο πνεύμονα): ο πνεύμονας εφάπτεται στο θωρακικό τοίχωμα.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμοθώρακας. Αναζητήστε: αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα και τη γραμμή του σπλαγχνικού υπεζωκότα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Αέρας στην υπεζωκοτική κοιλότητα· γραμμή του σπλαγχνικού υπεζωκότα στο χείλος του πνεύμονα.
- Σε κατακεκλιμένο ασθενή συγκεντρώνεται κυρίως πρόσθια και βασικά (μπορεί να μη φαίνεται στην ακτινογραφία).
- Μετατόπιση του μεσοθωρακίου, συνοδό υποδόριο εμφύσημα, πνευμομεσοθωράκιο, κάταγμα πλευράς.
- Εξετάστε με παράθυρο πνεύμονα· στο παράθυρο μεσοθωρακίου διαφεύγει.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο [δεξιό/αριστερό] ημιθωράκιο παρατηρείται πρόσθια εντοπιζόμενος πνευμοθώρακας. Δεν παρατηρείται μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Συνυπάρχει [κάταγμα πλευράς/υποδόριο εμφύσημα].*

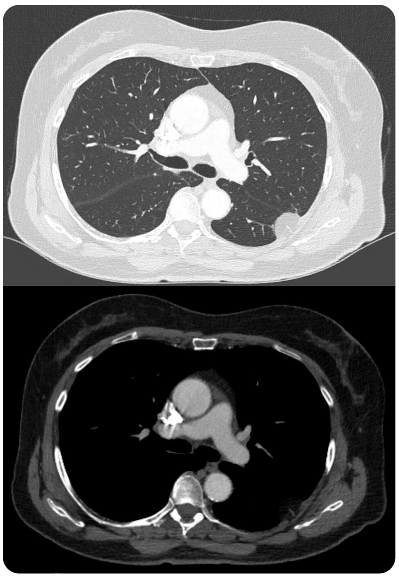
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Πομφόλυγες ή κύστεις (έχουν τοιχώματα, δεν είναι υπεζωκοτική γραμμή).
- Πνευμομεσοθωράκιο (αέρας στο μεσοθωράκιο, γύρω από τα αγγεία και την τραχεία).
- Δερματική πτυχή (σπάνια στην αξονική).

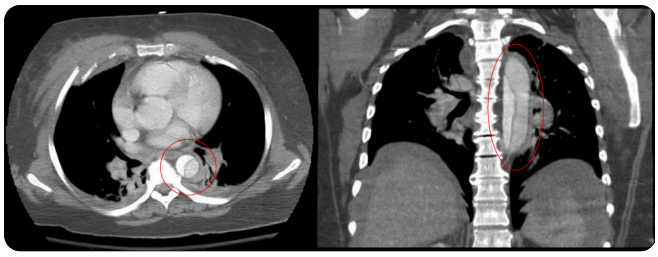
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Αναφέρετε κάθε νέο πνευμοθώρακα· σε μηχανικά αεριζόμενο ασθενή ακόμη και μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να μεγαλώσει γρήγορα.

20 · Διαχωρισμός αορτής



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική αξονική θώρακα με σκιαγραφικό: ομοιογενής αυλός της αορτής, χωρίς κρημνό.



Σε αυτή την εικόνα: διαχωρισμός αορτής. Αναζητήστε: ενδοτοιχωματικό κρημνό που χωρίζει τον αληθή από τον ψευδή αυλό.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ενδοτοιχωματικός κρημνός στον αυλό της αορτής που χωρίζει τον αληθή από τον ψευδή αυλό.
- Συμμετοχή της ανιούσας αορτής (Stanford A) ή μόνο της κατιούσας αορτής (Stanford B);
- Συμμετοχή κλάδων: υπεραορτικοί κλάδοι, κοιλιακή αρτηρία, άνω μεσεντέρια αρτηρία, νεφρικές αρτηρίες· αιμάτωση οργάνων.
- Στη φάση χωρίς σκιαγραφικό, έσω μετατοπισμένη ενδοτοιχωματική ασβέστωση και υπέρπυκνο ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα· περικαρδιακή συλλογή.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται ενδοτοιχωματικός κρημνός που ξεκινά [από την ανιούσα αορτή/περιφερικότερα της αριστερής υποκλείδιας αρτηρίας] και εκτείνεται έως το επίπεδο [...]· εύρημα συμβατό με διαχωρισμό αορτής τύπου Stanford [A/B]. Συμμετοχή των υπεραορτικών κλάδων, της κοιλιακής αρτηρίας, της άνω μεσεντέριας αρτηρίας και των νεφρικών αρτηριών [...]. Περικαρδιακή συλλογή [υπάρχει/δεν παρατηρείται]. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό.*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Τέχνημα σφύξης (κίνησης) στη ρίζα της αορτής.
- Τέχνημα γραμμώσεων (από φλέβα με πυκνό σκιαγραφικό).
- Περικαρδιακό κόλπωμα ή περιαορτικό λίπος.

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Κρίσιμο εύρημα· ενημερώστε αμέσως, ιδίως για διαχωρισμό τύπου Α.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

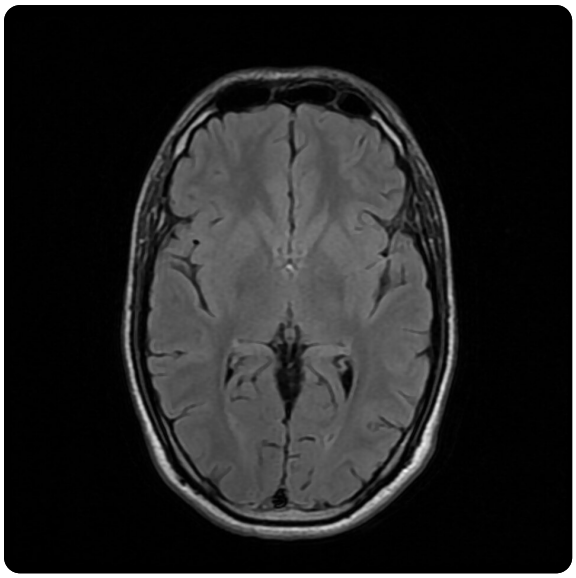
Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ)

Τα 10 συχνότερα ευρήματα στη μαγνητική εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης και γόνατος.

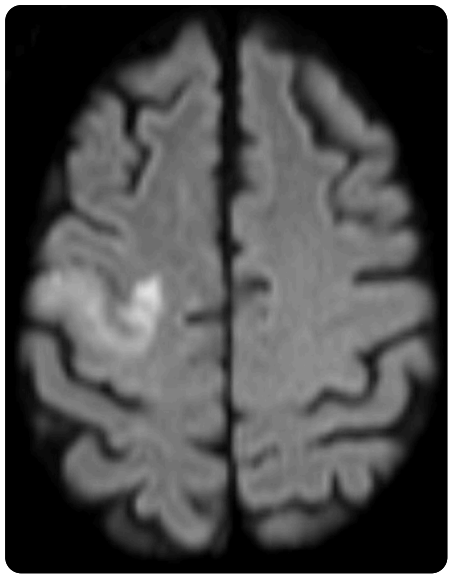
Τα ευρήματα αυτής της ενότητας και η επείγουσα προτεραιότητά τους:

21 · Οξύ έμφρακτο (DWI)	Ναι
22 · Πλάκες σκλήρυνσης κατά πλάκας	Όχι
23 · Γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού (γλοιοβλάστωμα)	
24 · Μηνιγγίωμα	Όχι
25 · Εγκεφαλικό απόστημα	Ναι
26 · Αδένωμα υπόφυσης	
27 · Οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου	
28 · Συμπίεση νωτιαίου μυελού	Ναι
29 · Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)	Όχι
30 · Ρήξη μηνίσκου	Όχι

21 · Οξύ έμφρακτο (DWI)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (FLAIR): χωρίς μεταβολή σήματος στο παρέγχυμα.



Σε αυτή την εικόνα: οξύ έμφρακτο στη DWI. Αναζητήστε: φωτεινή περιοχή στη DWI, σκοτεινή στον ADC.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Υπερέντονη περιοχή στη DWI (υψηλή τιμή b).
- Υπόεντονο σήμα της ίδιας περιοχής στον χάρτη ADC: πραγματικός περιορισμός διάχυσης.
- Αντιστοιχία με αγγειακή περιοχή.
- Στην πρώιμη φάση μπορεί να μην είναι εμφανές στη FLAIR (η αναντιστοιχία DWI-FLAIR είναι σημαντική για την κλινική).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στην αγγειακή περιοχή της [δεξιάς/αριστερής] [MCA] παρατηρείται περιοχή υπερέντονη στη DWI και χαμηλού σήματος στον χάρτη ADC, με περιορισμό διάχυσης· εύρημα συμβατό με οξύ ισχαιμικό έμφρακτο.*

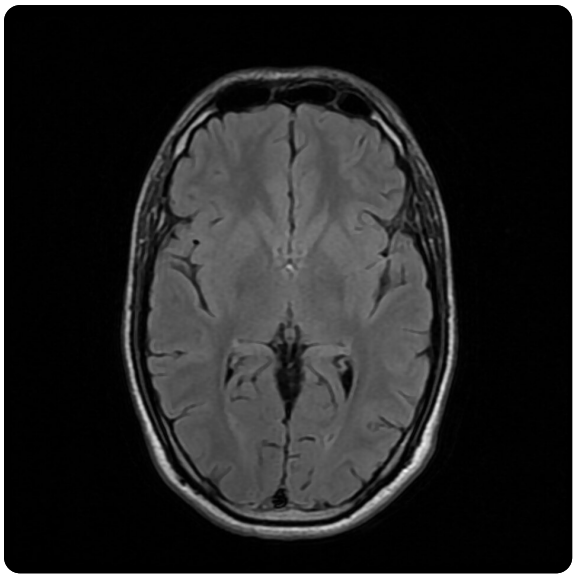
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Φαινόμενο T2 shine-through (φωτεινό στη DWI, αλλά φωτεινό και στον ADC).
- Απόστημα (κεντρικός περιορισμός, λεπτή δακτυλιοειδής ενίσχυση).
- Όγκος υψηλής κυτταροβρίθειας (λέμφωμα), επιδερμοειδής κύστη, μεταϊκταλικές αλλοιώσεις.

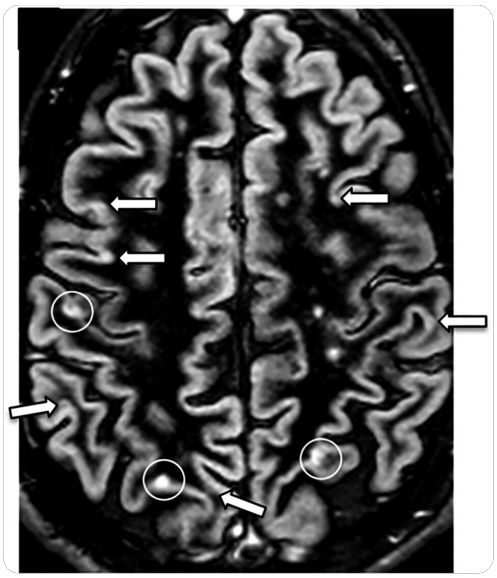
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Ενημερώστε αμέσως τον κλινικό ιατρό για το οξύ έμφρακτο.

22 · Πλάκες σκλήρυνσης κατά πλάκας



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (FLAIR): ομοιογενής περικοιλιακή λευκή ουσία.



Σε αυτή την εικόνα: απομυελινωτικές πλάκες. Αναζητήστε: ωοειδείς υπερέντονες βλάβες σε T2/FLAIR με τυπική εντόπιση.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Υπερέντονες βλάβες σε T2/FLAIR με περικοιλιακή, παραφλοιώδη/φλοιώδη, υποσκηνιδιακή και νωτιαία εντόπιση.
- Ωοειδείς βλάβες κάθετες στο μεσολόβιο («δάκτυλα του Dawson»).
- Ενίσχυση στις ενεργές βλάβες (συχνά σε σχήμα ανοικτού δακτυλίου).
- Αριθμός και εντόπιση των βλαβών, και νέες ή ενισχυόμενες βλάβες σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στην περικοιλιακή και παραφλοιώδη λευκή ουσία παρατηρούνται ωοειδείς υπερέντονες βλάβες σε T2/FLAIR, κάθετες στο μεσολόβιο· μπορεί να είναι συμβατές με απομυελινωτική νόσο. Ενισχυόμενη βλάβη [παρατηρείται/δεν παρατηρείται]. Νέα βλάβη σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση […].*

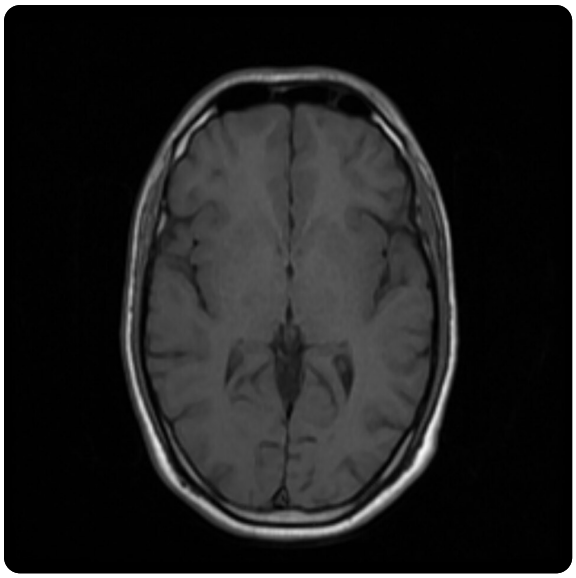
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Νόσος μικρών αγγείων (μεγαλύτερη ηλικία, υποφλοιώδης και εν τω βάθει λευκή ουσία, το μεσολόβιο συνήθως διατηρείται).
- Μη ειδικές εστίες λευκής ουσίας που συνοδεύουν την ημικρανία.
- Αγγειίτιδα, ADEM, άλλες απομυελινωτικές νόσοι.

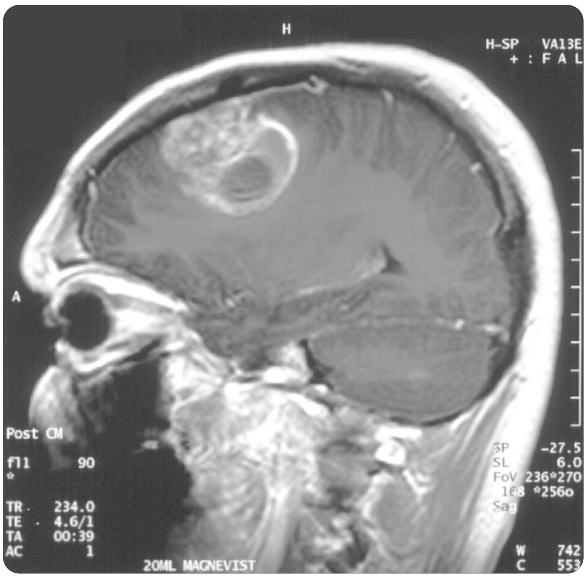
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Ως απεικονιστικό εύρημα δεν είναι επείγον· η νέα και ταχεία νευρολογική επιδείνωση είναι κλινικό επείγον.

23 · Γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού (γλοιοβλάστωμα)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (T1): ομοιογενές παρέγχυμα, χωρίς ενισχυόμενη βλάβη.



Σε αυτή την εικόνα: γλοιοβλάστωμα σε σειρά με σκιαγραφικό. Αναζητήστε: ανώμαλη παχιά δακτυλιοειδή ενίσχυση και κεντρική νέκρωση.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Ανώμαλη, παχιά, οζώδης δακτυλιοειδής ενίσχυση.
- Κεντρική νέκρωση· περιφερικά εκτεταμένο υπερέντονο οίδημα και διήθηση σε T2/FLAIR.
- Φαινόμενο μάζας· μπορεί να επεκτείνεται μέσω του μεσολοβίου στο αντίθετο ημισφαίριο.
- Εστίες αιμορραγίας (SWI/GRE) και αυξημένη αιμάτωση.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται ενδοαξονική εξεργασία με [δεξιά/αριστερή] [λοβώδη] εντόπιση, με ανώμαλη παχύτοιχη περιφερική ενίσχυση και κεντρικό νεκρωτικό στοιχείο, καθώς και περιβάλλον αγγειογενές οίδημα· πιθανολογείται πρωτίστως γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται μετάσταση και απόστημα.*

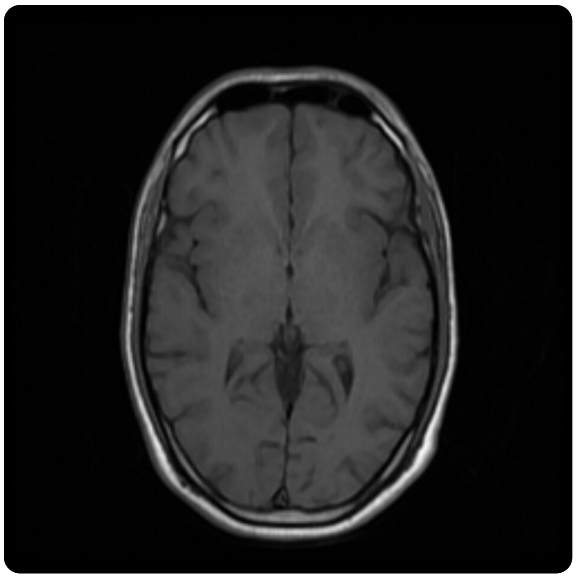
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Μετάσταση (συχνά στο όριο φαιάς-λευκής ουσίας, συνήθως πολλαπλές).
- Απόστημα (λεπτό ομαλό τοίχωμα, έντονος περιορισμός διάχυσης στο κέντρο).
- Λέμφωμα, ψευδοογκώδης απομυελινωτική βλάβη.

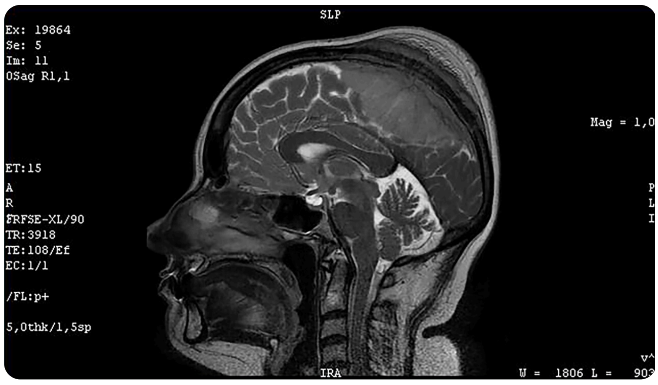
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Αν υπάρχει εγκεφαλικός εγκολεασμός ή έντονο φαινόμενο μάζας, αμέσως· διαφορετικά ενημερώστε τον κλινικό ιατρό την ίδια ημέρα.

24 · Μηνιγγίωμα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (T1): χωρίς μάζα κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας.



Σε αυτή την εικόνα: μηνιγγίωμα. Αναζητήστε: εξωαξονική μάζα με ευρεία βάση στη σκληρά μήνιγγα και ομοιογενή ενίσχυση.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Εξωαξονική μάζα με ευρεία βάση πρόσφυσης στη σκληρά μήνιγγα.
- Ομοιογενής, έντονη ενίσχυση· σημείο της σκληρομηνιγγικής ουράς.
- Σχισμή ΕΝΥ και αγγεία μεταξύ μάζας και εγκεφάλου (ενδείξεις εξωαξονικής θέσης).
- Υπερόστωση του γειτονικού οστού· μπορεί να υπάρχει ασβέστωση.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Πλησίον [της δεξιάς/της αριστερής] [κυρτότητας/του δρεπάνου/της πτέρυγας του σφηνοειδούς] παρατηρείται μάζα διαστάσεων ... mm, με βάση στη σκληρά μήνιγγα, εξωαξονική εντόπιση, ομοιογενή ενίσχυση και σημείο σκληρομηνιγγικής ουράς· εύρημα συμβατό με μηνιγγίωμα. Οίδημα στο παρακείμενο παρέγχυμα [υπάρχει/δεν υπάρχει].*

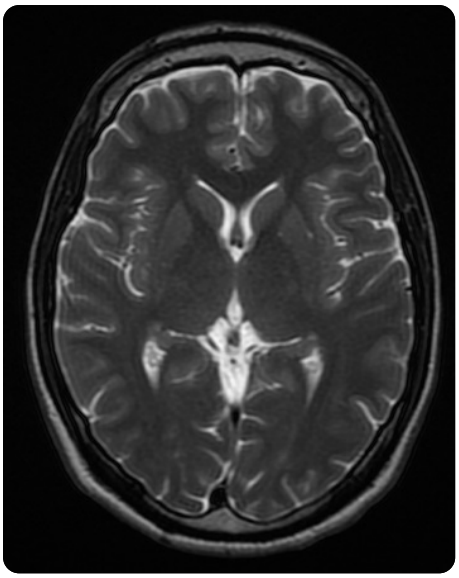
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Μετάσταση στη σκληρά μήνιγγα.
- Μονήρης ινώδης όγκος, λέμφωμα.
- Αιθουσαίο σβάννωμα στη γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία (επέκταση στον έσω ακουστικό πόρο).

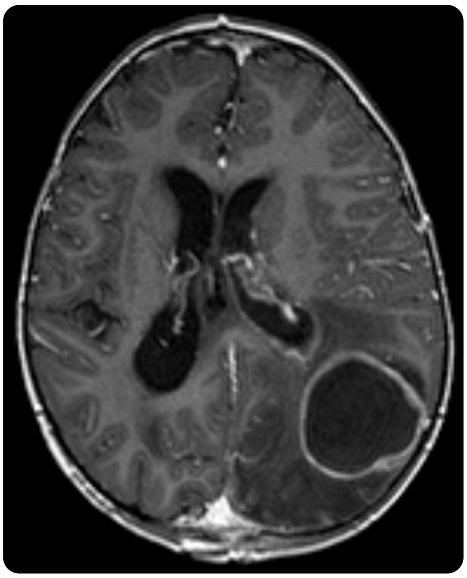
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Συνήθως δεν είναι επείγον· αν υπάρχει έντονο οίδημα ή φαινόμενο μάζας, ενημερώστε την ίδια ημέρα.

25 · Εγκεφαλικό απόστημα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (T2): χωρίς εστιακή βλάβη στο παρέγχυμα.



Σε αυτή την εικόνα: εγκεφαλικό απόστημα. Αναζητήστε: λεπτή ομαλή δακτυλιοειδή ενίσχυση και κεντρικό περιορισμό διάχυσης.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Λεπτή, ομαλή δακτυλιοειδής ενίσχυση (το τοίχωμα προς την κοιλία μπορεί να είναι λεπτότερο).
- Υπόεντονο περιθώριο της κάψας στο T2.
- Έντονος κεντρικός περιορισμός διάχυσης (φωτεινό στη DWI, σκοτεινό στον ADC).
- Περιβάλλον αγγειογενές οίδημα· αναζητήστε σημεία διάνοιξης στις κοιλίες (κοιλιίτιδα).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται βλάβη με [δεξιά/αριστερή] [λοβώδη] εντόπιση, με λεπτή ομαλή δακτυλιοειδή ενίσχυση και έντονο κεντρικό περιορισμό διάχυσης στη DWI, καθώς και περιβάλλον οίδημα· εύρημα συμβατό με απόστημα.*

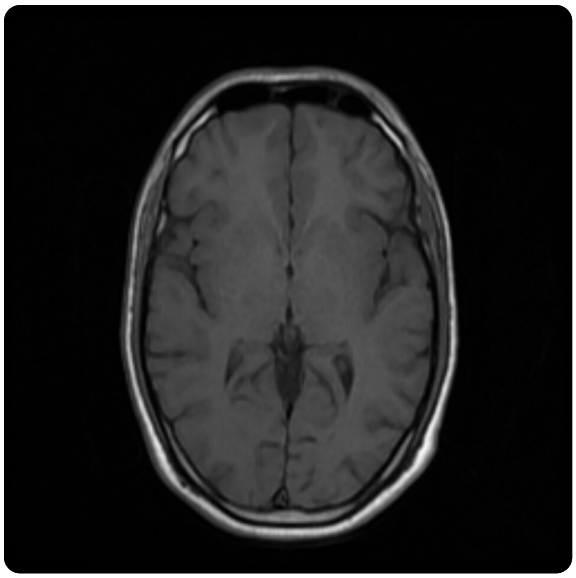
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Νεκρωτικός όγκος ή μετάσταση (παχύ και ανώμαλο τοίχωμα, συνήθως χωρίς κεντρικό περιορισμό διάχυσης).
- Αιμάτωμα σε φάση απορρόφησης.
- Ψευδοογκώδης απομυελινωτική βλάβη.

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Ενημερώστε αμέσως στην ίδια εφημερία· αν υπάρχει διάνοιξη στις κοιλίες ή φαινόμενο μάζας, είναι κρίσιμο εύρημα.

26 · Αδένωμα υπόφυσης



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (T1): τουρκικό εφίππιο και υπόφυση φυσιολογικού μεγέθους.



Σε αυτή την εικόνα: αδένωμα υπόφυσης. Αναζητήστε: εφιππιακή-υπερεφιππιακή μάζα και τη σχέση της με το οπτικό χίασμα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Μακροαδένωμα (10 mm και άνω): εφιππιακή και υπερεφιππιακή επέκταση, «μέση» στο επίπεδο του εφιππιακού διαφράγματος (εικόνα «χιονάνθρωπου»).
- Συμπίεση του οπτικού χιάσματος, διήθηση του σηραγγώδους κόλπου (περιβολή της καρωτίδας).
- Μικροαδένωμα: εστία που ενισχύεται καθυστερημένα σε σχέση με τον φυσιολογικό αδένα στις δυναμικές σειρές με σκιαγραφικό.
- Αιμορραγία (υπερέντονη στο T1) και αιφνίδια κλινική εικόνα: αποπληξία.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται ενισχυόμενη μάζα με εφιππιακή και υπερεφιππιακή επέκταση, διαστάσεων ... mm, που [πιέζει/δεν πιέζει] το οπτικό χίασμα· εύρημα συμβατό με μακροαδένωμα υπόφυσης. Διήθηση του σηραγγώδους κόλπου [πιθανολογείται/δεν παρατηρείται].*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Κρανιοφαρυγγίωμα (κυστικό στοιχείο, ασβέστωση).
- Μηνιγγίωμα (σκληρομηνιγγική ουρά· ο αδένας διακρίνεται χωριστά), κύστη της σχισμής του Rathke.
- Ανεύρυσμα (κενό ροής· πρέπει οπωσδήποτε να αποκλειστεί πριν από επέμβαση), φυσιολογική υπερπλασία.

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Το αιμορραγικό αδένωμα (αποπληξία) με αιφνίδια κεφαλαλγία και απώλεια όρασης είναι επείγον. Στις άλλες περιπτώσεις γνωματεύεται ως ρουτίνα.

27 · Οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική οσφυϊκή μαγνητική: μεσοσπονδύλια διαστήματα διατηρημένα, σωλήνας και τρήματα ελεύθερα.



Σε αυτή την εικόνα: κήλη δίσκου. Αναζητήστε: εστιακή μετατόπιση υλικού του δίσκου έξω από το μεσοσπονδύλιο διάστημα και τη σχέση της με τη ρίζα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Εστιακή μετατόπιση υλικού του δίσκου έξω από τα όρια του μεσοσπονδύλιου διαστήματος.
- Προβολή (ευρεία βάση), εξώθηση (στενός αυχένας, κρανιακή/ουραία μετανάστευση) ή απομονωμένο τεμάχιο;
- Εντόπιση σε αξονικές T2: κεντρική, παραμέση (υπαρθρική), τρηματική, εξωτρηματική.
- Συμπίεση της αντίστοιχης νευρικής ρίζας και στένωση του κεντρικού σωλήνα.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο επίπεδο L4-L5 παρατηρείται [δεξιά/αριστερή] παραμέση [προβολή/εξώθηση] δίσκου που στενεύει το πλάγιο κόλπωμα και πιέζει την [δεξιά/αριστερή] νευρική ρίζα L5. Κεντρικός σπονδυλικός σωλήνας [ελεύθερος/στενωμένος], μεσοσπονδύλια τρήματα [ελεύθερα/στενωμένα].*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Αρθρική κύστη των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων.
- Όγκος νευρικού ελύτρου (σβάννωμα), επισκληρίδιο απόστημα.
- Συνενωμένη νευρική ρίζα· μετεγχειρητική ουλή (ενισχύεται, ο κηλώδης δίσκος ενισχύεται περιφερικά).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Αν υπάρχει σοβαρή στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και κλινική εικόνα ιππουρίδας, είναι επείγον· ενημερώστε αμέσως. Τα υπόλοιπα είναι ρουτίνα.

28 · Συμπίεση νωτιαίου μυελού



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική σπονδυλικής στήλης: ο δακτύλιος ΕΝΥ γύρω από τον μυελό διατηρείται.



Σε αυτή την εικόνα: συμπίεση μυελού. Αναζητήστε: επισκληρίδια βλάβη που παραμορφώνει τον μυελό και αλλαγή σήματος στον μυελό.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Επισκληρίδια μάζα, οστικό τεμάχιο ή δίσκος στον σπονδυλικό σωλήνα που παραμορφώνει τον μυελό.
- Απώλεια του δακτυλίου ΕΝΥ γύρω από τον μυελό.
- Υπερέντονο σήμα στο T2 μέσα στον μυελό (οίδημα / μυελοπάθεια).
- Σύμπτωση σπονδυλικού σώματος, οπισθώθηση του οπίσθιου τοιχώματος· ελέγξτε όλη τη σπονδυλική στήλη (μπορεί να αφορά πολλά επίπεδα).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο επίπεδο [...] παρατηρείται επισκληρίδιο στοιχείο μαλακών μορίων που προέρχεται από το σπονδυλικό σώμα, στενεύει τον σπονδυλικό σωλήνα και συμπιέζει τον μυελό· συνυπάρχει αύξηση του σήματος του μυελού στο T2. Τα ευρήματα είναι συμβατά με μεταστατική επισκληρίδια συμπίεση του νωτιαίου μυελού. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό.*

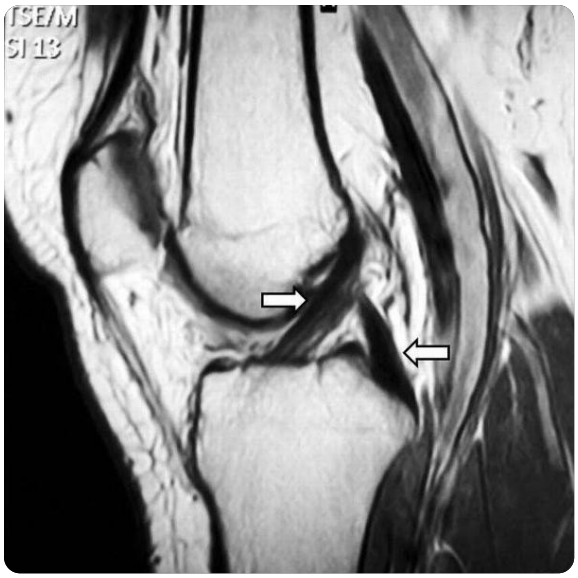
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Επισκληρίδιο απόστημα (περιφερική ενίσχυση στη σειρά με σκιαγραφικό, σπονδυλοδισκίτιδα).
- Επισκληρίδιο αιμάτωμα.
- Εκφυλιστική στένωση του σπονδυλικού σωλήνα (βραδεία εξέλιξη, σε πολλά επίπεδα).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Κρίσιμο εύρημα· ενημερώστε αμέσως.

29 · Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική γόνατος: ο ΠΧΣ είναι ευθεία, συνεχής ταινία χαμηλού σήματος.



Σε αυτή την εικόνα: ρήξη ΠΧΣ. Αναζητήστε: διακοπή της συνέχειας των ινών και δευτερογενή ευρήματα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Διακοπή της συνέχειας των ινών του ΠΧΣ· απώλεια της φυσιολογικής εικόνας ευθείας ταινίας.
- Διόγκωση του συνδέσμου, κυματοειδές περίγραμμα και αύξηση του σήματος στο T2.
- Δευτερογενή ευρήματα: οίδημα μυελού των οστών (θλάση) στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στο οπισθοπλάγιο κνημιαίο πλατό.
- Πρόσθια μετατόπιση της κνήμης, υπερβολική κάμψη του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, κάταγμα Segond.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται ρήξη ολικού πάχους του ΠΧΣ, χωρίς ορατή συνέχεια των ινών, με οιδηματώδες και κυματοειδές περίγραμμα· συνυπάρχει οίδημα μυελού των οστών (θλάση) στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στο οπισθοπλάγιο κνημιαίο πλατό.*

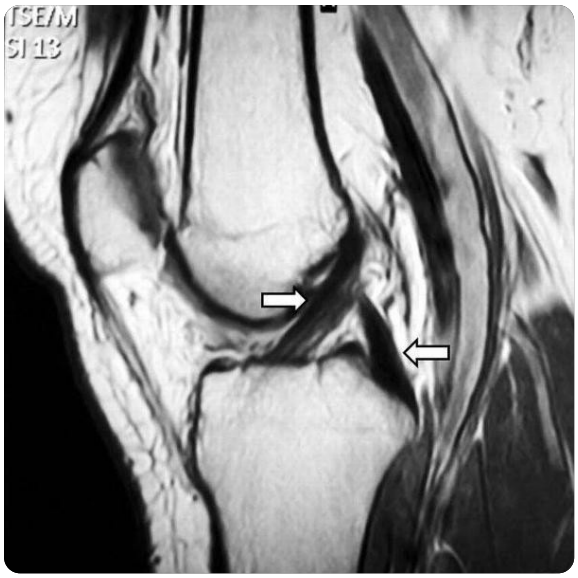
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Βλεννώδης εκφύλιση (παχύς και φωτεινός σύνδεσμος, αλλά οι ίνες είναι συνεχείς).
- Μερική ρήξη.
- Γαγγλιακή κύστη του ΠΧΣ.

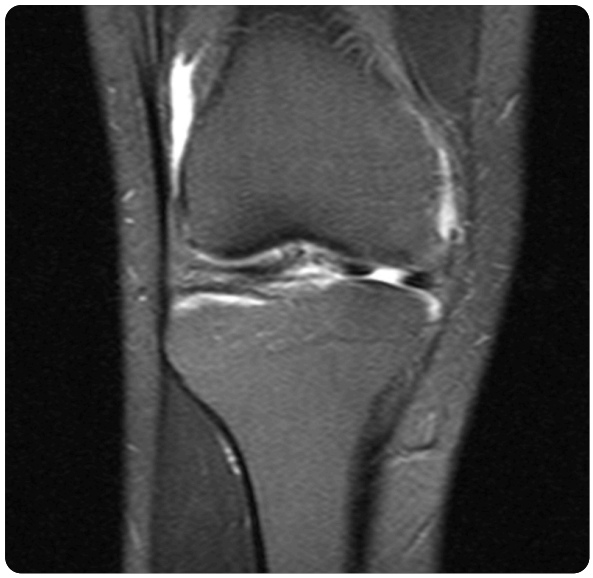
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Δεν είναι επείγον· γνωματεύεται ως ρουτίνα.

30 · Ρήξη μηνίσκου



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική μαγνητική γόνατος: μηνίσκοι τριγωνικοί και ομοιογενώς χαμηλού σήματος.



Σε αυτή την εικόνα: ρήξη μηνίσκου. Αναζητήστε: αύξηση σήματος που φτάνει στην αρθρική επιφάνεια ή παραμόρφωση του σχήματος.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Αύξηση σήματος εντός του μηνίσκου που φτάνει στην αρθρική επιφάνεια σε ακολουθίες PD με καταστολή λίπους (σε τουλάχιστον δύο τομές).
- Παραμόρφωση, σμίκρυνση ή «κομμένη» εικόνα του μηνίσκου.
- Ρήξη τύπου «λαβής κάδου»: τμήμα μετατοπισμένο στη μεσοκονδύλια εντομή (εικόνα «διπλού οπίσθιου χιαστού συνδέσμου»).
- Ρήξεις ρίζας και προβολή (εξώθηση) του μηνίσκου.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο [οπίσθιο κέρας] του [έσω/έξω] μηνίσκου παρατηρείται [λοξή/οριζόντια/ακτινωτή] αύξηση σήματος που εκτείνεται στην [κάτω] αρθρική επιφάνεια· εύρημα συμβατό με ρήξη.*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Ενδοουσιακή εκφύλιση (το σήμα δεν φτάνει στην αρθρική επιφάνεια).
- Εγκάρσιος σύνδεσμος ή μηνισκομηριαίοι σύνδεσμοι (φυσιολογικές δομές).
- Τέχνημα μαγικής γωνίας (σε ακολουθίες με βραχύ ΤΕ).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Δεν είναι επείγον· σε «κλειδωμένο» γόνατο αναφέρετε την ίδια ημέρα μετατοπισμένη ρήξη τύπου «λαβής κάδου».

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

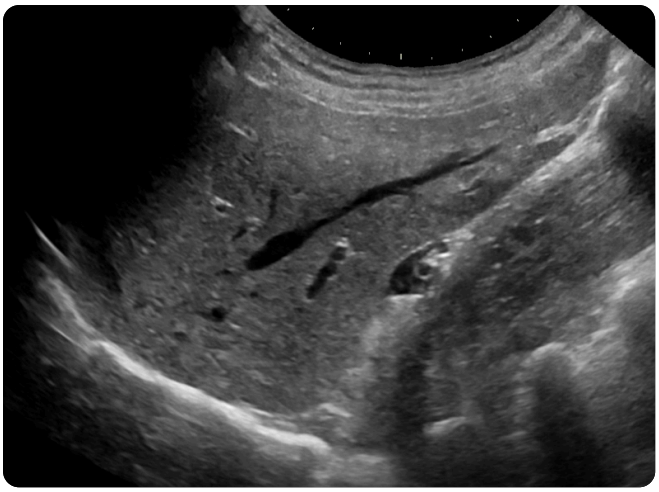
Υπερηχογράφημα (υπέρηχος και POCUS)

Τα 10 συχνότερα ευρήματα στο υπερηχογράφημα κοιλίας, νεφρών, πνευμόνων και φλεβών.

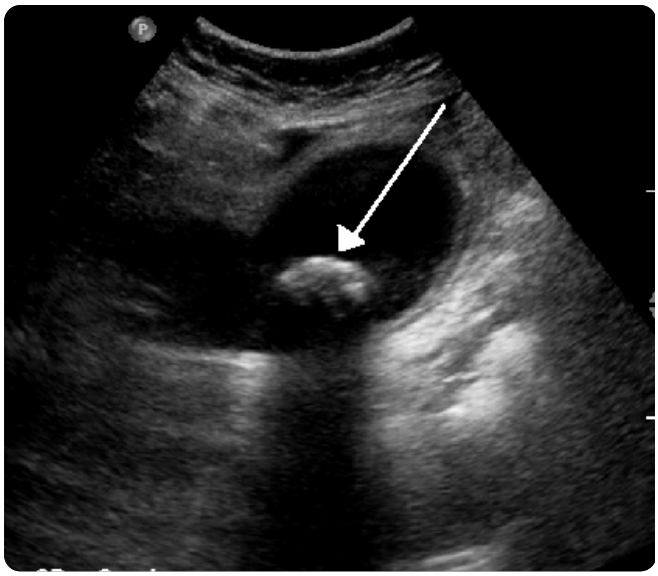
Τα ευρήματα αυτής της ενότητας και η επείγουσα προτεραιότητά τους:

31 · Χολολιθίαση	Όχι
32 · Οξεία χολοκυστίτιδα	Ναι
33 · Ηπατική στεάτωση	Όχι
34 · Ηπατικό απόστημα	
35 · Υδρονέφρωση	
36 · Απλή νεφρική κύστη	Όχι
37 · FAST: ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison	Ναι
38 · Υπερηχογράφημα πνευμόνων: γραμμές B	
39 · Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT)	Ναι
40 · Ασκίτης	

31 · Χολολιθίαση



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: περιοχή ήπατος και χοληδόχου κύστης φυσιολογική.



Σε αυτή την εικόνα: χολόλιθοι. Αναζητήστε: υπερηχογενή εστία, οπίσθια ακουστική σκιά και μετακίνηση με την αλλαγή θέσης.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Υπερηχογενής(-είς) εστία(-ες) στον αυλό της χοληδόχου κύστης.
- Οπίσθια ακουστική σκιά.
- Μετατόπιση με την αλλαγή θέσης του ασθενούς.
- Αν η χοληδόχος κύστη είναι γεμάτη λίθους: σημείο τοιχώματος–ηχούς–σκιάς (WES).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στον αυλό της χοληδόχου κύστης παρατηρούνται υπερηχογενείς εστίες με οπίσθια ακουστική σκιά, που μετακινούνται με την αλλαγή θέσης· ευρήματα συμβατά με χολολιθίαση. Το πάχος του τοιχώματος είναι φυσιολογικό, δεν παρατηρείται περιχολοκυστικό υγρό.*

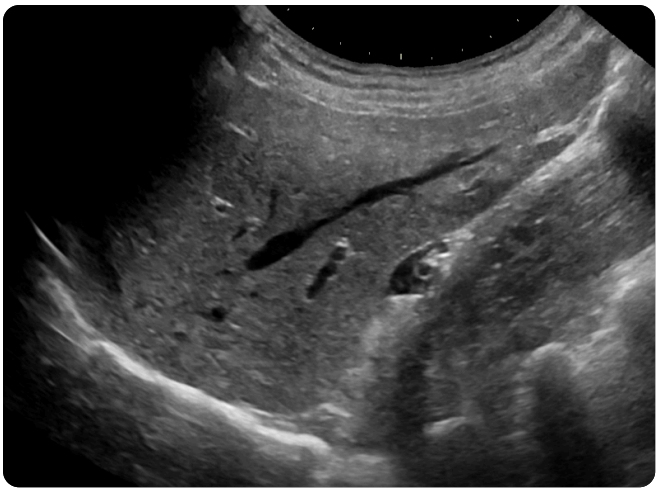
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Πολύποδας (χωρίς σκιά, δεν μετακινείται, προσκολλημένος στο τοίχωμα).
- Χολώδης λάσπη (χωρίς σκιά, στρωματοποιείται).
- Αέρια εντέρου, πορσελάνινη χοληδόχος κύστη (ασβέστωση του τοιχώματος).

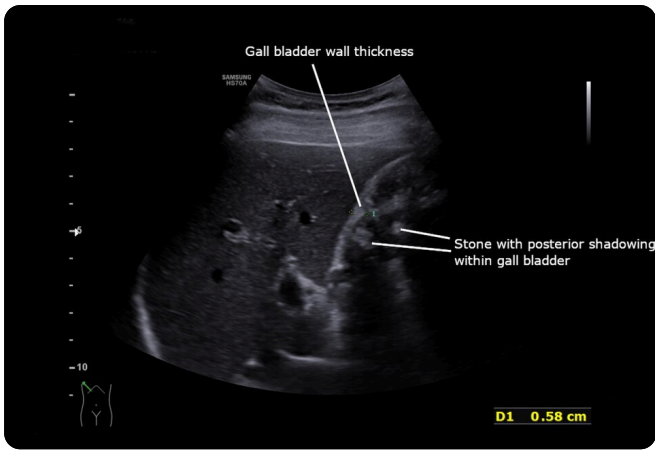
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Από μόνο του δεν είναι επείγον· ενημερώστε αν υπάρχουν ευρήματα χολοκυστίτιδας ή λιθίασης χοληδόχου πόρου.

32 · Οξεία χολοκυστίτιδα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: περιοχή ήπατος και χοληδόχου κύστης φυσιολογική.



Σε αυτή την εικόνα: οξεία χολοκυστίτιδα. Αναζητήστε: λίθο, πάχυνση τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Συνήθως ενσφηνωμένος λίθος στον αυχένα.
- Πάχυνση τοιχώματος (συνήθως πάνω από 3 mm) και οίδημα τοιχώματος.
- Περιχολοκυστικό υγρό, διάταση της χοληδόχου κύστης, θετικό υπερηχογραφικό σημείο Murphy.
- Ενδείξεις επιπλοκών: ανωμαλία τοιχώματος και μεμβράνες (γάγγραινα), αέριο στο τοίχωμα (εμφυσηματώδης), έλλειμμα τοιχώματος (διάτρηση).

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Η χοληδόχος κύστη είναι διατεταμένη, με παχυσμένο και οιδηματώδες τοίχωμα· υπάρχει ενσφηνωμένος λίθος στον αυχένα, περιχολοκυστικό υγρό και θετικό υπερηχογραφικό σημείο Murphy. Ευρήματα συμβατά με οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα.*

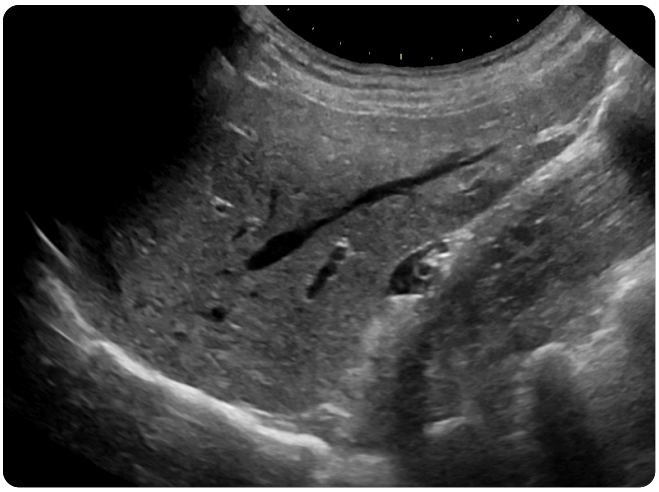
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Άλλα αίτια πάχυνσης του τοιχώματος: ηπατίτιδα, ασκίτης, καρδιακή ανεπάρκεια, υπολευκωματιναιμία, μεταγευματική χοληδόχος κύστη.
- Αδενομυομάτωση (τεχνήματα «ουράς κομήτη» στο τοίχωμα).
- Χρόνια χολοκυστίτιδα (μικρή χοληδόχος κύστη με παχύ τοίχωμα, αρνητικό σημείο Murphy).

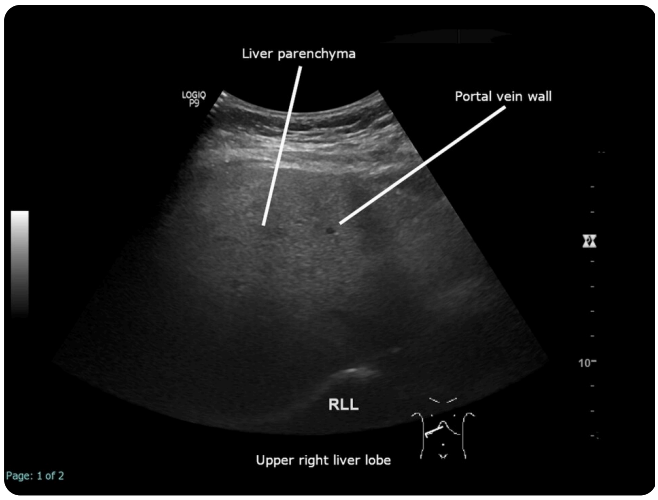
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Ενημερώστε τη χειρουργική ομάδα στην ίδια εφημερία· αμέσως αν υπάρχουν σημεία γάγγραινας, αερίου ή διάτρησης.

33 · Ηπατική στεάτωση



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα ήπατος: ηχογένεια παρόμοια με τον φλοιό του νεφρού, τα βαθύτερα τμήματα και το διάφραγμα διακρίνονται.



Σε αυτή την εικόνα: ηπατική στεάτωση. Αναζητήστε: αυξημένη ηχογένεια του παρεγχύματος και εξασθένηση του ήχου σε βάθος.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Αύξηση της ηχογένειας του ήπατος σε σχέση με τον φλοιό του νεφρού.
- Εξασθένηση του ήχου στα βαθύτερα τμήματα (οπίσθια εξασθένηση).
- Τα τοιχώματα της πυλαίας φλέβας και το διάφραγμα διακρίνονται δυσκολότερα.
- Οι εστιακές περιοχές χωρίς λίπος (π.χ. γύρω από την κοίτη της χοληδόχου κύστης) δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως μάζα.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Η ηχογένεια του ηπατικού παρεγχύματος είναι διάχυτα αυξημένη σε σχέση με τον φλοιό του νεφρού και παρατηρείται εξασθένηση του ήχου στα βαθύτερα τμήματα· ευρήματα συμβατά με ηπατική στεάτωση. Δεν παρατηρείται εστιακή βλάβη.*

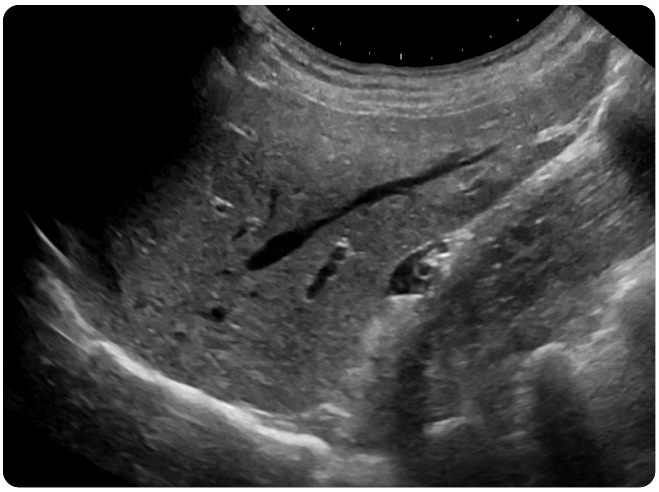
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Χρόνια ηπατοπάθεια / ίνωση (αδρή ηχοδομή, ανώμαλο περίγραμμα).
- Λανθασμένη ρύθμιση της ενίσχυσης (gain).
- Εστιακή λιπώδης διήθηση ή περιοχή χωρίς λίπος που εκλαμβάνεται ως πραγματική μάζα (τα αγγεία δεν μετατοπίζονται).

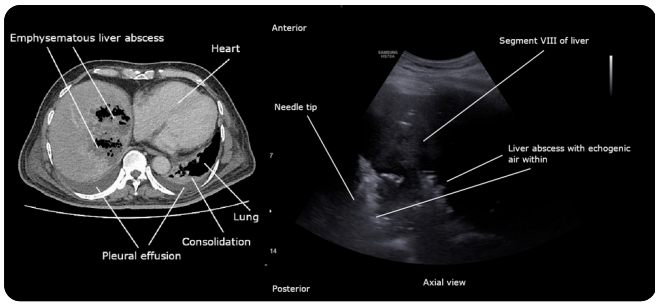
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Δεν είναι επείγον.

34 · Ηπατικό απόστημα



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα ήπατος: ομοιογενές παρέγχυμα, χωρίς εστιακή βλάβη.



Σε αυτή την εικόνα: ηπατικό απόστημα. Αναζητήστε: σύνθετη βλάβη με ανώμαλο τοίχωμα και εσωτερικές ηχώ.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Υποηχογενής ή σύνθετη κυστική βλάβη με ανώμαλο τοίχωμα, εσωτερική ηχογένεια και διαφραγμάτια.
- Οπίσθια ακουστική ενίσχυση.
- Περιφερικός υποηχογενής δακτύλιος (οίδημα).
- Αν υπάρχει αέριο: υπερηχογενείς εστίες και «βρώμικη» σκιά.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο ήπαρ παρατηρείται σύνθετη κυστική βλάβη με ανώμαλο τοίχωμα, εσωτερική ηχογένεια και διαφραγμάτια· σε συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα είναι ενδεικτική αποστήματος. Συνιστάται εκτίμηση με αξονική με σκιαγραφικό και ως προς τις επεμβατικές θεραπευτικές επιλογές.*

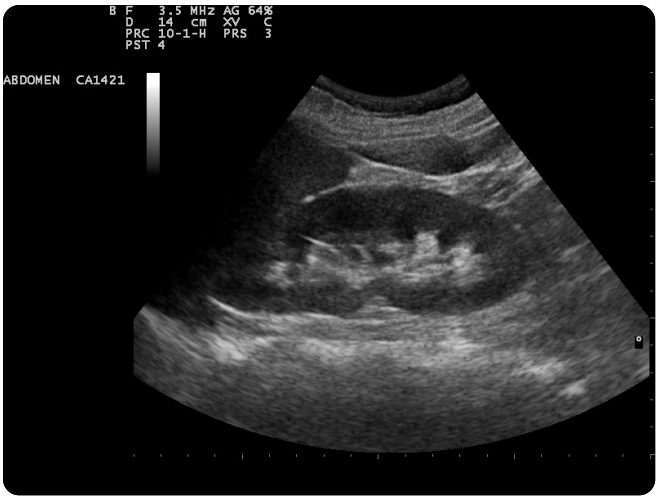
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Νεκρωτική μετάσταση.
- Υδατίδα κύστη (θυγατρικά κυστίδια, αποκόλληση μεμβράνης, ασβέστωση τοιχώματος).
- Αιμάτωμα, κυστικό νεόπλασμα.

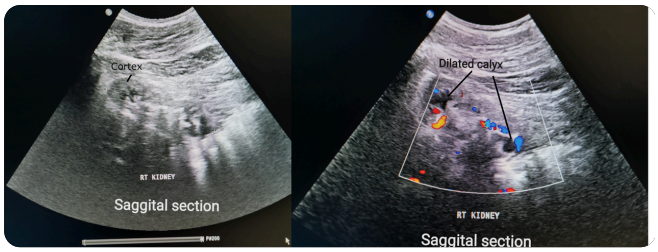
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Ενημερώστε την ίδια ημέρα· σε εικόνα σήψης είναι επείγον.

35 · Υδρονέφρωση



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών: ηχογενής κεντρικός κόλπος, αποχετευτικό σύστημα χωρίς διάταση.



Σε αυτή την εικόνα: υδρονέφρωση. Αναζητήστε: διατεταμένη πύελο και κάλυκες που επικοινωνούν μεταξύ τους.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Άνηχη διάταση της νεφρικής πυέλου και των καλύκων που επικοινωνούν μεταξύ τους.
- Βαθμός: ήπια, μέτρια, σοβαρή (λέπτυνση του παρεγχύματος).
- Διάταση του κεντρικού ή περιφερικού ουρητήρα· αναζητήστε λίθο στο επίπεδο αυτό (UPJ, UVJ).
- Εσωτερικές ηχώ ή επίπεδο υγρού-υπολειμμάτων στο πυελοκαλυκικό σύστημα: υποψία πυονέφρωσης.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στον [δεξιό/αριστερό] νεφρό παρατηρείται [ήπια/μέτρια/σοβαρή] διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος, με πάχος παρεγχύματος [διατηρημένο/λεπτυσμένο]. Ο κεντρικός ουρητήρας [παρατηρείται διατεταμένος]· στο ορατό τμήμα δεν παρατηρείται λίθος.*

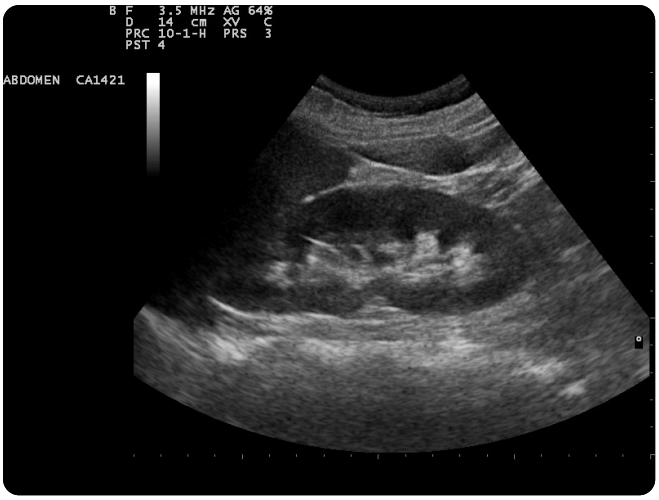
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Παραπυελικές κύστεις (δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ούτε με την πύελο).
- Εξωνεφρική πύελος· ήπια διάταση λόγω γεμάτης ουροδόχου κύστης (επανεξετάστε μετά την ούρηση).
- Αγγεία του νεφρικού κόλπου (διαφοροδιάγνωση με έγχρωμο Doppler).

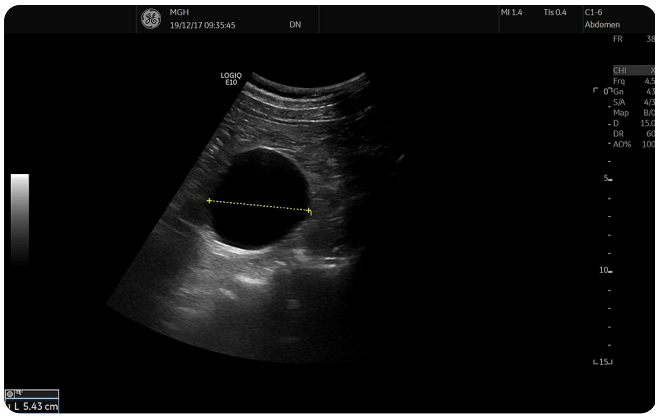
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Ο πυρετός και τα σημεία λοίμωξης (υποψία πυονέφρωσης), ο μονήρης νεφρός ή η αμφοτερόπλευρη απόφραξη είναι επείγοντα· ενημερώστε αμέσως.

36 · Απλή νεφρική κύστη



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών: ομοιογενές παρέγχυμα, χωρίς εστιακή βλάβη.



Σε αυτή την εικόνα: απλή νεφρική κύστη. Αναζητήστε: άνηχο περιεχόμενο, λεπτό τοίχωμα και οπίσθια ακουστική ενίσχυση.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Άνηχο περιεχόμενο.
- Λεπτό, ομαλό τοίχωμα· χωρίς διαφραγμάτια, συμπαγές στοιχείο ή ασβέστωση.
- Οπίσθια ακουστική ενίσχυση.
- Χωρίς εσωτερική ροή στο έγχρωμο Doppler.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στο [άνω/μέσο/κάτω] τμήμα του [δεξιού/αριστερού] νεφρού παρατηρείται απλή φλοιώδης κύστη διαστάσεων ... mm, με λεπτό ομαλό τοίχωμα, άνηχη, με οπίσθια ακουστική ενίσχυση.*

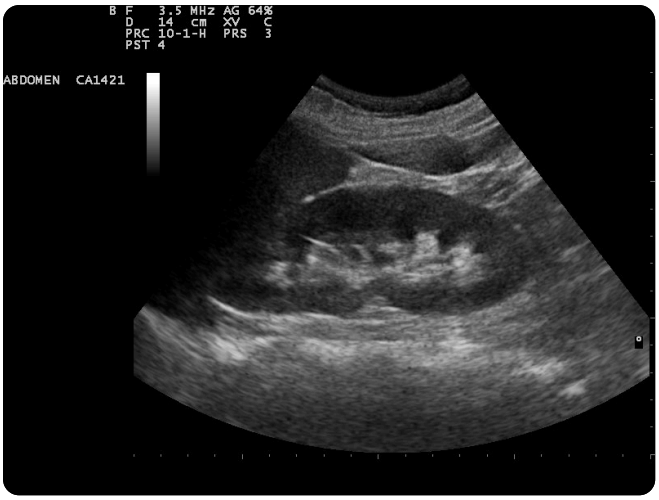
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Σύνθετη κύστη (διαφραγμάτια, παχύ τοίχωμα, συμπαγές στοιχείο): πρέπει να χαρακτηριστεί με αξονική ή μαγνητική.
- Υδρονεφρωτικός κάλυκας ή παραπυελική κύστη.
- Εκκόλπωμα κάλυκα.

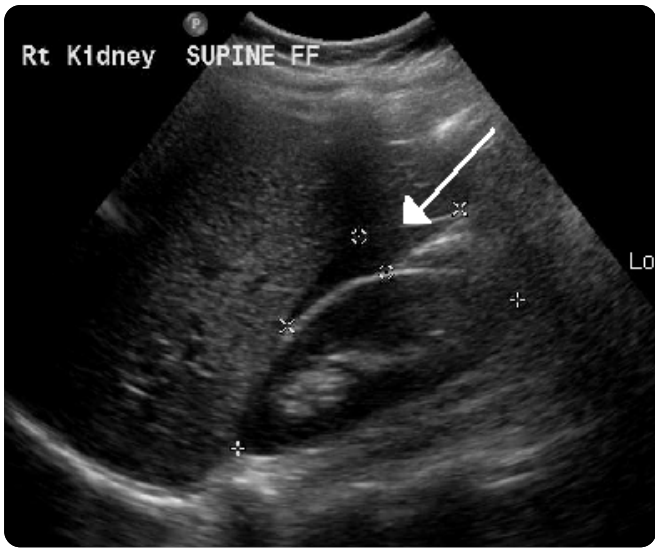
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Όχι Δεν είναι επείγον.

37 · FAST: ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογική εικόνα δεξιού άνω τεταρτημορίου: χωρίς υγρό μεταξύ ήπατος και νεφρού.



Σε αυτή την εικόνα: ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison. Αναζητήστε: άνηχη ταινία μεταξύ ήπατος και νεφρού.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Άνηχη ταινία ή τριγωνική συλλογή υγρού μεταξύ ήπατος και δεξιού νεφρού.
- Η περιοχή γύρω από το κάτω άκρο του ήπατος: ένα από τα πρώτα σημεία όπου φαίνεται μικρή ποσότητα υγρού.
- Εκτιμήστε τα μαζί με τα άλλα παράθυρα: σπληνονεφρικό, πύελος, περικάρδιο, υπεζωκοτικές γωνίες.
- Ερμηνεύστε το μαζί με την αιμοδυναμική κατάσταση· η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί σειριακά.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *eFAST (ώρα ...): παρατηρείται ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison (θετικό). Σπληνονεφρικό: [...]. Πυελικό: [...]. Περικάρδιο: [...]. Υπεζωκοτικές γωνίες: [...]. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στην ομάδα τραύματος.*

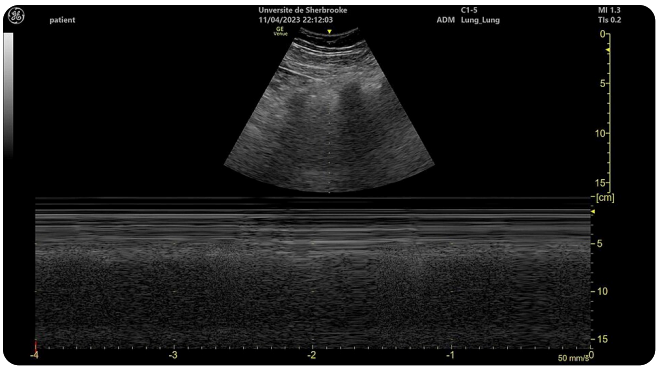
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Περινεφρικός λιπώδης ιστός (υποηχογενής, αλλά δεν μοιάζει με υγρό).
- Περιεχόμενο χοληδόχου κύστης ή δωδεκαδακτύλου.
- Προϋπάρχων ασκίτης, νεφρική κύστη.

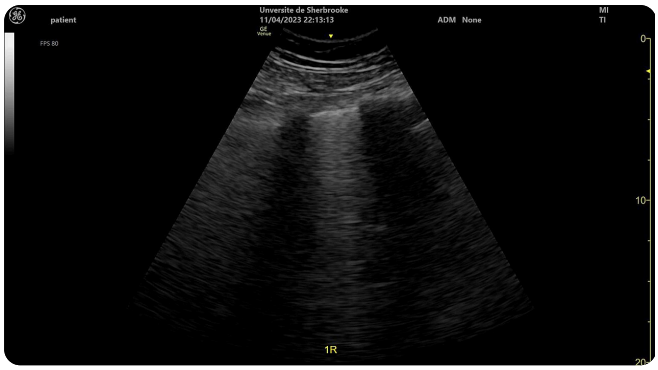
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Το θετικό FAST σε τραύμα, ιδίως με αιμοδυναμική αστάθεια, αναφέρεται αμέσως.

38 · Υπερηχογράφημα πνευμόνων: γραμμές B



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα πνευμόνων: οριζόντιες γραμμές A κάτω από την υπεζωκοτική γραμμή και ολίσθηση του υπεζωκότα.



Σε αυτή την εικόνα: γραμμές B. Αναζητήστε: κάθετα τεχνήματα από τον υπεζωκότα έως το κάτω μέρος της οθόνης, που εξαλείφουν τις γραμμές A.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Κάθετα υπερηχογενή τεχνήματα που ξεκινούν από την υπεζωκοτική γραμμή και εκτείνονται έως το κάτω μέρος της οθόνης.
- Εξαλείφουν τις γραμμές A και κινούνται μαζί με την ολίσθηση του υπεζωκότα.
- Τρεις ή περισσότερες γραμμές B σε ένα μεσοπλεύριο διάστημα: πρότυπο B (διάμεσο σύνδρομο).
- Κατανομή: αμφοτερόπλευρη διάχυτη (όπως στο καρδιογενές οίδημα) ή εστιακή (πνευμονία, θλάση);

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρούνται αμφοτερόπλευρα, σε πολλές ζώνες, τρεις ή περισσότερες γραμμές B ανά μεσοπλεύριο διάστημα (πρότυπο B)· η υπεζωκοτική γραμμή είναι ομαλή και η ολίσθηση του υπεζωκότα διατηρείται. Σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα εκτιμάται υπέρ διάμεσου συνδρόμου / πνευμονικού οιδήματος.*

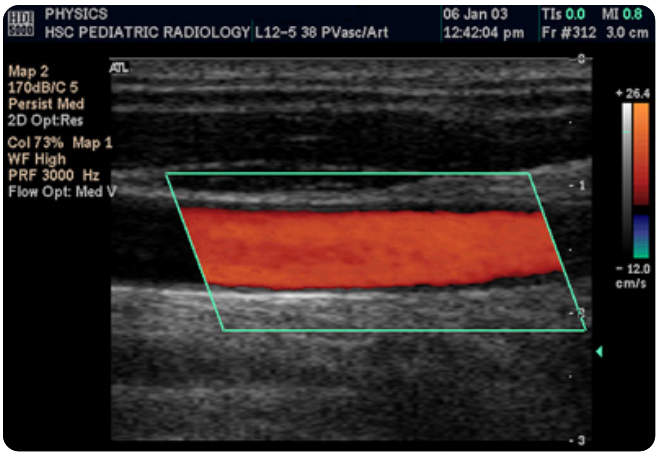
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Βραχέα τεχνήματα που δεν εξαλείφουν τις γραμμές A (γραμμές Z).
- Λίγες μεμονωμένες γραμμές B στις βάσεις μπορεί να παρατηρούνται και σε φυσιολογικά άτομα.
- Κάθετα τεχνήματα λόγω υποδόριου εμφυσήματος (ξεκινούν από τον υποδόριο ιστό, όχι από τον υπεζωκότα).

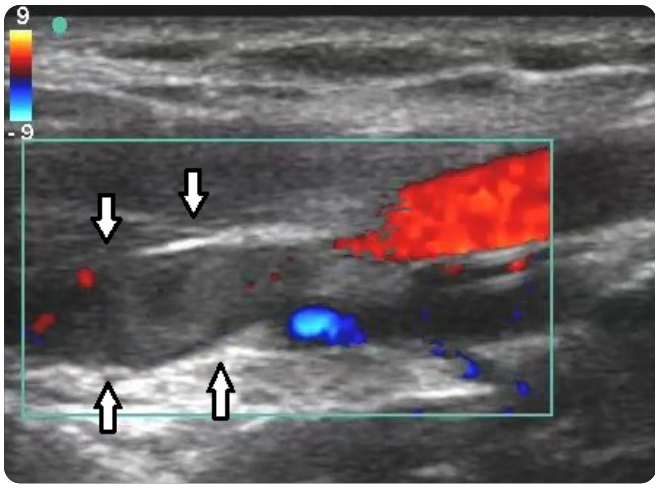
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Ανάλογα με την κλινική εικόνα· σε νέο εύρημα και σε υποξαιμικό ασθενή ενημερώστε.

39 · Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT)



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό έγχρωμο Doppler: ο αυλός του αγγείου γεμίζει πλήρως με χρώμα.



Σε αυτή την εικόνα: εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Αναζητήστε: φλέβα που δεν συμπιέζεται και θρόμβο στον αυλό.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Η φλέβα δεν συμπιέζεται πλήρως με την πίεση της κεφαλής (βασικό κριτήριο).
- Ηχογενής ή υποηχογενής θρόμβος στον αυλό· στον οξύ θρόμβο η φλέβα είναι διατεταμένη.
- Έλλειμμα πλήρωσης ή απουσία ροής στο έγχρωμο Doppler.
- Απώλεια της απάντησης στον χειρισμό ενίσχυσης ροής· η απώλεια της αναπνευστικής φασικότητας κεντρικότερα υποδηλώνει απόφραξη λαγόνιων ή κεντρικότερων φλεβών.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Στην [δεξιά/αριστερή] κοινή μηριαία και μηριαία φλέβα παρατηρείται υποηχογενής θρόμβος που πληροί τον αυλό, χωρίς συμπίεση της φλέβας με την πίεση και με απουσία ροής στο έγχρωμο Doppler· εύρημα συμβατό με οξεία εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό.*

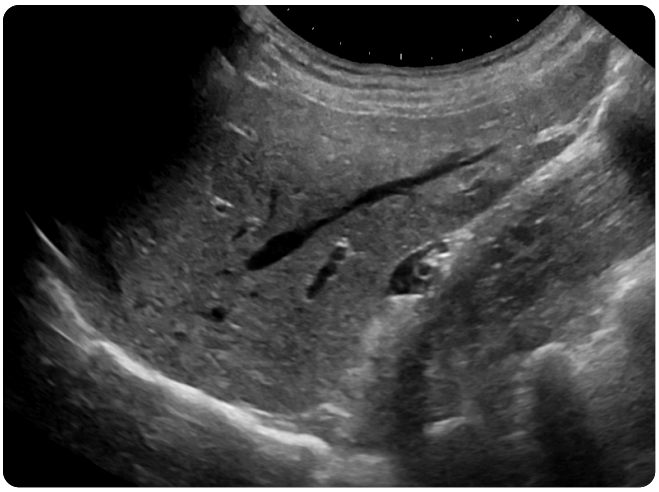
ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Λεμφαδένας (έχει πύλη, δεν είναι αγγείο).
- Κύστη Baker ή ρήξη της· αιμάτωμα.
- Χρόνιος θρόμβος (ηχογενής, προσκολλημένος στο τοίχωμα, μικρή φλέβα, παράπλευρα)· ηχογενής ροή λόγω βραδείας ροής (συμπιέζεται με την πίεση).

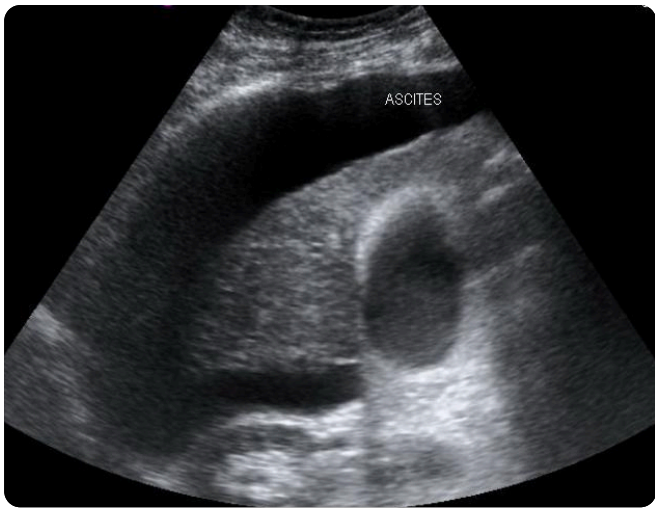
ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ναι Η κεντρική DVT αναφέρεται στην ίδια εφημερία.

40 · Ασκίτης



Φυσιολογική αναφορά · Φυσιολογικό υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: χωρίς ελεύθερο υγρό γύρω από το ήπαρ.



Σε αυτή την εικόνα: ασκίτης. Αναζητήστε: άνηχο ελεύθερο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

- Άνηχο ελεύθερο υγρό περιηπατικά, περισπληνικά, στον θύλακο του Morison, στις παρακολικές αύλακες και στην πύελο.
- Εντερικές έλικες που «επιπλέουν» μέσα στο υγρό.
- Εσωτερικές ηχώ, διαφραγμάτια ή επίπεδο υγρού-υπολειμμάτων: επιπλεγμένο υγρό (μολυσμένο, αιμορραγικό, κακόηθες).
- Η ασφαλέστερη και βαθύτερη θέση πριν από την παρακέντηση.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

> *Παρατηρείται [μικρή/μέτρια/μεγάλη] ποσότητα άνηχου ελεύθερου υγρού (ασκίτης) περιηπατικά, περισπληνικά και στην πύελο. Δεν παρατηρείται εσωτερική ηχογένεια ή διαφραγμάτια.*

ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ

- Γεμάτη ουροδόχος κύστη, κυστική πυελική μάζα.
- Περιχαρακωμένη συλλογή ή απόστημα.
- Υπεζωκοτικό ή περικαρδιακό υγρό (πάνω από το διάφραγμα).

ΕΠΕΙΓΟΝ;

Ανάλογα με την περίπτωση Από μόνο του δεν είναι επείγον. Σε τραύμα σκεφτείτε αιμοπεριτόναιο, ενώ με πυρετό και κοιλιακό άλγος μολυσμένο ασκίτη.

ΣΥΝΟΨΗ

Επείγον; Τα 40 ευρήματα με μια ματιά

Για γρήγορη απόφαση στην εφημερία: ποιο εύρημα αναφέρεται αμέσως και ποιο εκτιμάται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα.

#	ΕΥΡΗΜΑ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΠΕΙΓΟΝ;
01	Πνευμοθώρακας	Ακτινογραφία	Ναι
02	Υπεζωκοτική συλλογή	Ακτινογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
03	Λοβώδης πνευμονία (πύκνωση)	Ακτινογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
04	Ατελεκτασία	Ακτινογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
05	Καρδιομεγαλία	Ακτινογραφία	Όχι
06	Πνευμονικό οίδημα	Ακτινογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
07	Πνευμοπεριτόναιο (ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα)	Ακτινογραφία	Ναι
08	Απόφραξη λεπτού εντέρου	Ακτινογραφία	Ναι
09	Κάταγμα περιφερικής κερκίδας	Ακτινογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
10	Οστεοαρθρίτιδα γόνατος	Ακτινογραφία	Όχι
11	Επισκληρίδιο αιμάτωμα	Αξονική Τομογραφία	Ναι

#	ΕΥΡΗΜΑ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΠΕΙΓΟΝ;
12	Υποσκληρίδιο αιμάτωμα	Αξονική Τομογραφία	Ναι
13	Υπαραχνοειδής αιμορραγία	Αξονική Τομογραφία	Ναι
14	Ενδοεγκεφαλική (ενδοπαρεγχυματική) αιμορραγία	Αξονική Τομογραφία	Ναι
15	Οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό (αξονική)	Αξονική Τομογραφία	Ναι
16	Υδροκέφαλος	Αξονική Τομογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
17	Πνευμονική εμβολή (αξονική αγγειογραφία)	Αξονική Τομογραφία	Ναι
18	Αδιαφάνεια θολής υάλου	Αξονική Τομογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
19	Πνευμοθώρακας (αξονική)	Αξονική Τομογραφία	Ναι
20	Διαχωρισμός αορτής	Αξονική Τομογραφία	Ναι
21	Οξύ έμφρακτο (DWI)	Μαγνητική Τομογραφία	Ναι
22	Πλάκες σκλήρυνσης κατά πλάκας	Μαγνητική Τομογραφία	Όχι
23	Γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού (γλοιοβλάστωμα)	Μαγνητική Τομογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
24	Μηνιγγίωμα	Μαγνητική Τομογραφία	Όχι
25	Εγκεφαλικό απόστημα	Μαγνητική Τομογραφία	Ναι
26	Αδένωμα υπόφυσης	Μαγνητική Τομογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση

#	ΕΥΡΗΜΑ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΠΕΙΓΟΝ;
27	Οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου	Μαγνητική Τομογραφία	Ανάλογα με την περίπτωση
28	Συμπίεση νωτιαίου μυελού	Μαγνητική Τομογραφία	Ναι
29	Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)	Μαγνητική Τομογραφία	Όχι
30	Ρήξη μηνίσκου	Μαγνητική Τομογραφία	Όχι
31	Χολολιθίαση	Υπερηχογράφημα	Όχι
32	Οξεία χολοκυστίτιδα	Υπερηχογράφημα	Ναι
33	Ηπατική στεάτωση	Υπερηχογράφημα	Όχι
34	Ηπατικό απόστημα	Υπερηχογράφημα	Ανάλογα με την περίπτωση
35	Υδρονέφρωση	Υπερηχογράφημα	Ανάλογα με την περίπτωση
36	Απλή νεφρική κύστη	Υπερηχογράφημα	Όχι
37	FAST: ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison	Υπερηχογράφημα	Ναι
38	Υπερηχογράφημα πνευμόνων: γραμμές B	Υπερηχογράφημα	Ανάλογα με την περίπτωση
39	Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT)	Υπερηχογράφημα	Ναι
40	Ασκίτης	Υπερηχογράφημα	Ανάλογα με την περίπτωση

Πρόταση ενημέρωσης

Όταν κοινοποιείτε ένα κρίσιμο εύρημα, προσθέστε στη γνωμάτευση: «Το εύρημα κοινοποιήθηκε στις … ώρα, κατόπιν επικοινωνίας με …».

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από το Wikimedia Commons, με ανοικτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, δημόσιος τομέας, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή και απλώς άλλαξαν μέγεθος ή περικόπηκαν. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
6. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
7. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
8. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
9. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
10. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
11. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
13. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
14. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
15. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
16. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
17. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
18. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
19. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
20. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
21. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
22. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
23. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
24. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
25. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
26. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)

27. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
28. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
29. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
30. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
31. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
32. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
33. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
34. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
35. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
36. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
37. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
38. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
39. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
40. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
41. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
42. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
43. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
44. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
45. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
46. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
47. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
48. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
49. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
50. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
51. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
52. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
53. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
54. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
55. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
56. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα το Δώρο 2 · Οδηγός Ερμηνείας Εικόνων. Είδατε τα ευρήματα αυτού του άτλαντα· με τις λίστες μίας σελίδας ανά εξέταση του οδηγού, ακολουθώντας την ίδια σειρά σε κάθε ανάγνωση, θα τα εντοπίζετε χωρίς να σας διαφεύγουν.

Για να δοκιμάσετε να γράφετε τα ευρήματα με δικά σας λόγια, περάστε στη συνέχεια στο **Δώρο 3 · 100 Πρακτικά Περιστατικά**.